

Medbook PRU 醫療核保指引手冊

跳至：[器官分類索引](#)

版本日期：2025年7月2日

引言

本手冊以簡明、扼要原則列出名種常見健康問題及處理手法，純粹作為營業員的一般指引。鑑於健康問題及處理手法種類繁多，未能一一盡錄。我們精心揀選核保部及營業員最常遇到的健康問題作為參考，希望提升營業員對名種常見健康問題之認識，以縮減核保程序，提升服務質素。

承保條款會因不同產品保障範圍而有所不同，以及會根據最新內部指引而不時修訂。核保部會因應會根據投保人個別的健康情況，在必需要的情況下，要求投保人提供額外的健康資料或進行額外的身體檢查，以制訂最終的承保條款。

本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

核保部

醫療核保指引



■ 使用指引	第 4 頁
■ 疾病索引 (按身體部位分類)	第 6 頁
■ 疾病總覽	第 7 – 190 頁
■ 註釋	第 191 頁
附件一：最新超聲波指引	第 192 - 193 頁
附件二：常見直接拒絕受保 / 延期受保原因	第 194 - 199 頁
附件三：「誠保一生」危疾保 - 摯愛寶 (BCIM3) 「簡易投保」健康問題小貼士	第 200 - 207 頁

使用指引

本核保指引手冊適用於以下保障計劃

人壽保障：

- 美好人生保障計劃 (PLP2)
- 「快享錢」儲蓄保障計劃 (PC)
- 「守護家人」定期人壽保 (PLT)
- 「自主未來」保障計劃 (LFREE & LFREESP / LFREEM & LFREESPM)
- 守護健康危疾定期保 (CIT2) 之人壽部份
- 守護健康危疾加護保 (CIE3 / CIE3M) 之人壽部份
- 危疾首護保 (CIP2) 之人壽部份
- 「誠保一生」危疾保系列 (CIM3 / BCIM3 / CIM3M / BCIM3M) 之人壽部份

危疾保障：

- 守護健康危疾定期保 (CIT2) 之危疾部份
- 守護健康危疾加護保 (CIE3 / CIE3M) 之危疾部份
- 危疾首護保 (CIP2) 之危疾部份
- 特選危疾治療保 (CPE) 之危疾部份
- 「自主健康」危疾保 (ECI / ECIM) 之危疾部份
- 「自主健康」危疾多重保 (ECM / ECMM) 之危疾部份
- 「誠保一生」危疾保系列 (CIM3 / BCIM3 / CIM3M / BCIM3M) 之危疾部份

早期危疾保障：

- 守護健康危疾定期保 (CIT2) 之早期危疾部份
- 守護健康危疾加護保 (CIE3 / CIE3M) 之早期危疾部份
- 危疾首護保 (CIP2) 之早期危疾部份
- 特選危疾治療保 (CPE) 之早期危疾部份
- 「誠保一生」危疾保系列 (CIM3 / BCIM3 / CIM3M / BCIM3M) 之早期危疾部份

醫療保障：

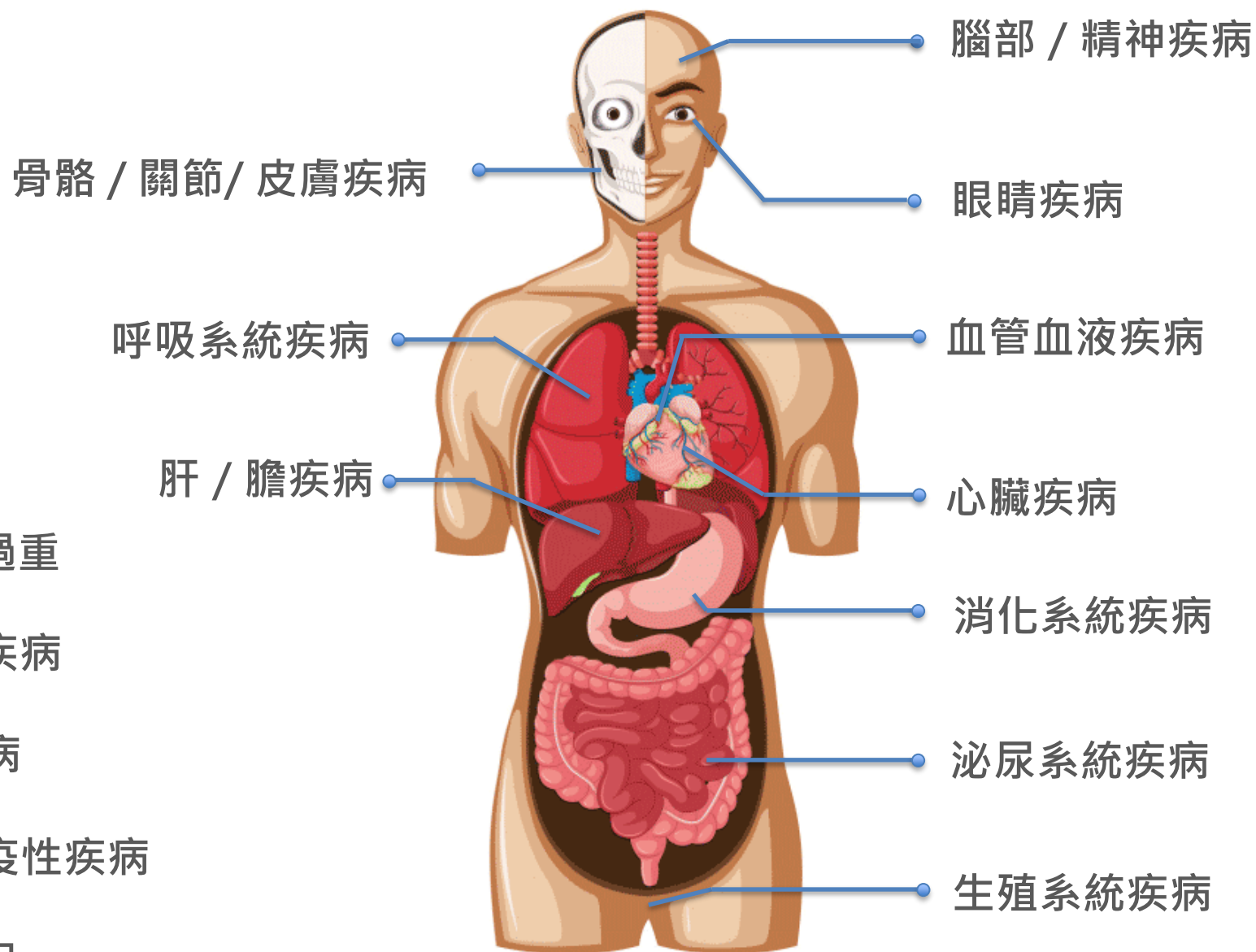
- 高端醫療自由行計劃 (MCVIP)
- 「摯為您」優悅醫療保險計劃 (PPM)
- 醫療加倍保 (PMP / PMPM)
- 終身保醫療計劃 (MLP / MLPM)
- 住院護惠計劃 (HCP)
- 智安心康健計劃 (HTPR / HTPRM)
- 自願醫保 (VHIS)
- 保誠加護一生住院現金儲蓄保險 (ENCASH)

癌症保障：

- 癌症全護計劃 (CP)
- 癌症保障360 (C360/C360R)
- 雋寶傳承保障計劃 (EGP / EGPM)
- 「自主健康」嚴重癌症保 (ECS / ECSM)

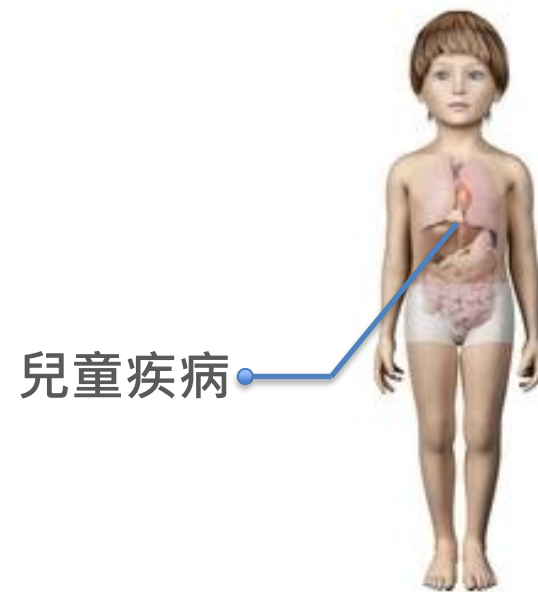
醫療核保指引

疾病索引（按身體部位分類）



其他：

- 三高 / 過重
- 甲狀腺疾病
- 乳房疾病
- 自體免疫性疾病
- 家族病史



疾病總覽

三高 / 過重

1. 高血壓
2. 高膽固醇血症
3. 過重
4. 前期糖尿病
5. 糖尿病
6. 妊娠糖尿病

甲狀腺疾病

1. 甲狀腺功能亢進症
2. 甲狀腺功能減退症
3. 甲狀腺結節
4. 甲狀腺癌

乳房疾病

1. 乳房良性疾病
2. 乳癌

自體免疫性疾病

1. 類風濕性關節炎
2. 銀屑病

腦部 / 精神疾病

1. 抑鬱症
2. 焦慮症
3. 泌乳素瘤

眼睛疾病

1. 白內障
2. 青光眼
3. 視網膜脫落

骨骼 / 關節 / 皮膚疾病

1. 退化性關節炎
2. 椎間盤突出
3. 痛風
4. 脊椎側彎
5. 濕疹 / 皮炎

呼吸系統疾病

1. 哮喘
2. 睡眠窒息症
3. 2019冠狀病毒病 (COVID-19)
4. 肺炎
5. 肺結節

血管血液疾病

1. 中風
2. 短暫性腦缺血發作
3. 地中海貧血

肝 / 膽疾病

1. 甲型肝炎
2. 乙型肝炎
3. 脂肪肝
4. 肝血管瘤
5. 膽石
6. 膽囊息肉

心臟疾病

1. 二尖瓣反流
2. 三尖瓣反流
3. 竇性心律不齊
4. 竇性心律過緩
5. 心房間隔缺損
6. 心室間隔缺損
7. 冠狀動脈性心臟病

消化系統疾病

1. 胃炎
2. 腸化生
3. 胃食道逆流
4. 消化性潰瘍
5. 痔瘡
6. 結腸癌
7. 結腸息肉
8. 幽門螺桿菌感染

兒童疾病

1. 川崎病
2. 早產
3. 新生兒黃疸
4. 自閉症
5. 專注力不足/過度活躍症

泌尿系統疾病

1. 血尿症
2. 蛋白尿症
3. 腎石
4. 腎血管平滑肌脂肪瘤

生殖系統疾病

1. 子宮纖維瘤
2. 子宮內膜異位症
3. 子宮 / 宮頸息肉
4. 宮頸炎
5. 宮頸上皮內瘤樣病變
6. 單純性卵巢囊腫
7. 卵巢癌
8. 卵巢畸胎瘤
9. 多囊卵巢綜合症
10. 前列腺特異性抗原上升
11. 前列腺鈣化灶
12. 良性前列腺增生

家族病史

1. 乳腺癌家族史
2. 卵巢癌家族史
3. 結腸直腸癌家族史
4. 帕金森病家族病史
5. 二型糖尿病家族史

三高 / 超重、
甲狀腺疾病、
乳房疾病、
自體免疫性疾病

三高 / 超重

1. 高血壓
2. 高膽固醇血症
3. 超重
4. 前期糖尿病
5. 糖尿病
6. 妊娠糖尿病

乳房疾病疾病

1. 乳房良性疾病
2. 乳癌

甲狀腺疾病



1. 甲狀腺功能亢進症
2. 甲狀腺功能減退症
3. 甲狀腺結節
4. 甲狀腺癌

自體免疫性疾病

1. 類風濕性關節炎
2. 銀屑病

高血壓 (Hypertension)

簡介

- 血壓持續高於理想水平
- 多數原因不明，小部分高血壓是由腎病、甲狀腺功能亢進症、腎上腺瘤等引致
- 理想血壓應為上壓 < 120 及下壓 < 80 ；如上壓 ≥ 140 或下壓 ≥ 90 則定義為高血壓

病徵

- 多無病徵，小部分高血壓病人會有腎病、甲狀腺功能亢進症、腎上腺瘤的病徵高

治療

- 服用降血壓藥、飲食控制、多做運動

考慮因素

- 血壓數值、身高體重、吸煙習慣等
- 考慮有否同時存在血糖過高或膽固醇過高情況

基本核保要求

- 驗身 (Medical Exam)

高血壓 (Hypertension)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
血壓低於 140 / 90 ; 並無任何其他心血管風險 (心血管風險：如吸煙習慣、過重、糖尿病、血脂異常等)	標準			
高血壓未受控	加價 至 拒絕受保			標準

高膽固醇血症 (Hyperlipidemia)

簡介

- 血液中膽固醇及 / 或三酸甘油脂水平過高
- 此為導致心血管疾病的主要因素之一

病徵

- 多數病人完全沒有病徵

治療

- 飲食控制及多做運動
- 服用降膽固醇或血脂藥物

考慮因素

- 身高體重、膽固醇水平、吸煙狀況等
- 考慮有否同時有血壓高或血糖過高情況

基本核保要求

- 血脂組合 (Lipid Profile)

高膽固醇血症（Hyperlipidemia）

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
血脂控制於理想水平 並無任何其他心血管風險	標準			
高血脂未受控	加價 至 拒絕受保			標準

過重 (Overweight)

簡介

- 身體積聚過多脂肪而引起的健康問題
- 體重指數 (BMI) 是一種可粗略顯示過重的標準
 - BMI (體重指數) 公式 = 體重 (公斤) / 身高 (米)²
- 亞洲成年人指標：
 - 過重：BMI 23 - 24.9 肥胖：BMI ≥ 25

治療

- 飲食控制及多做運動

考慮因素

- 血壓、體重指數、吸煙狀況、有否血糖過高或膽固醇過高情況等

基本核保要求

- 驗身 (Medical Exam) / 點對點樣本收集服務 (適用於特選客戶)
*如客人為成年人及 BMI ≥ 33

過重 (Overweight)

核保指引	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
過重	標準、加價至拒保 保費評級視乎體重指數 (BMI)、年齡、性別、 種族及其他心血管疾病風險因素			

前期糖尿病 (Pre-Diabetes)

簡介

- 糖耐量異常 (IGT) 和空腹血糖異常 (IFG) 描述了正常葡萄糖代謝和糖尿病之間的中間階段，稱為前期糖尿病，可預測患糖尿病和心血管疾病的風險
 - 空腹血糖異常 (IFG)：空腹血糖 (FBS) 5.6-6.9 mmol/L
 - 糖耐量異常 (IGT)：口服葡萄糖耐量測試 (OGTT) 兩小時後的血糖值為7.8至11.0mmol/L
 - 糖化血紅素 (HbA1c) 5.7-6.4%

病徵

- 口乾、尿頻、疲倦、體重下降等

治療

- 飲食控制及多做運動
- 服用降膽固醇或血脂藥物

考慮因素

- 血糖水平 (空腹血糖，糖化血色素)、血壓、血脂、腎功能、吸煙習慣、身體質量指數(BMI)、心血管疾病史

前期糖尿病 (Pre-Diabetes)

基本核保要求

1. 驗身 (Medical Exam)
2. 尿液分析：尿液常規檢驗 (MU)
3. 空腹血糖 (FBS)
4. 糖化血色素 (HbA1c)
5. 血脂組合 (Lipid Profile)
6. 如投保醫療保障，客戶需要額外提供(自費)以下檢查報告：
腎功能檢驗 (RFT)、靜態心電圖 (ECG)、主診醫生報告 (MAR)

*** 如客戶單獨投保醫療產品PPM / PMP / MCVIP / VHIS，或於保單行政部申請單獨增加醫療保障，以上項目 1 – 6 均須要自費進行**

前期糖尿病 (Pre-Diabetes)

核保指引

核保指引	人壽	早期危疾 / 危疾	癌症
已診斷為前期糖尿病患者或 空腹血糖 (FBS) 5.6-6.9 mmol/L 或 糖化血色素 (HbA1c) 5.7-6.4% ¹	加價 [#] 至拒絕受保		
#根據客人整體心血管風險，核保部有可能考慮給予標準級別。			
保費級別根據年齡、控制程度 (糖化血色素 HbA1c 及 空腹血糖 FBS)、吸煙習慣及其他心血管疾病風險因素而作評估 如要排除前期糖尿病，客戶需要提供最近的血葡萄糖耐量試驗 (OGTT)。			
¹ 根據美國糖尿聯會的定義			

前期糖尿病 (Pre-Diabetes)

核保指引

醫療	
已診斷為前期糖尿病患者或 空腹血糖 (FBS) 5.6-6.9 mmol/L 或 糖化血色素 (HbA1c) 5.7-6.4% ¹	+50% 及 不保事項# 視乎遞交的檢查及報告結果 #不保事項：任何因糖尿病及其併發症而引致之有關檢查或治療 包括但不限於缺血性心臟病, 中風及腎衰竭
如空腹血糖 (FBS) 或 糖化血色素 (HbA1c) 高過以上範圍	請參閱「糖尿病 (Diabetes) 」
如要排除前期糖尿病，客戶需要提供最近的血葡萄糖耐量試驗 (OGTT) 。	

糖尿病 (Diabetes)

簡介

- 糖尿病是一種慢性疾病，此病會增加患腦血管病
例如中風、短暫性腦缺血發作、心臟病、失明、視網膜病、腎病及神經系統疾病的機會
- 一型糖尿病：身體不能製造胰島素
二型糖尿病：身體對胰島素敏感度下降，絕大部分病人屬這類型
- 世界衛生組織 (WHO) 之糖尿病定義：
 - 空腹血糖 (FBS) ≥ 7 mmol/L
 - 糖化血色素 (HbA1c) $\geq 6.5\%$

病徵

- 口乾、尿頻、疲倦、體重下降、傷口難愈等

治療

- 飲食控制及多做運動
- 服用降膽固醇或血脂藥物

考慮因素

- 血糖水平 (空腹血糖，糖化血色素)、血壓、血脂、腎功能、吸煙習慣、身體質量指數(BMI)、心血管疾病史

糖尿病 (Diabetes)

基本核保要求

1. 驗身 (Medical Exam)
2. 尿液分析：尿液常規檢驗 (MU)
3. 空腹血糖 (FBS)
4. 糖化血色素 (HbA1c)
5. 血脂組合 (Lipid Profile)
6. 如投保醫療保障，客戶需要額外提供(自費)以下檢查報告：
腎功能檢驗 (RFT)、靜態心電圖 (ECG)、主診醫生報告 (MAR)

*** 如客戶單獨投保醫療產品PPM / PMP / MCVIP / VHIS，或於保單行政部申請單獨增加醫療保障，以上項目 1 – 6 均須要自費進行**

糖尿病 (Diabetes)

核保指引

人壽

早期危疾 / 危疾

癌症

已診斷為糖尿病患者或
空腹血糖 (FBS) ≥ 7 mmol/L 或
糖化血色素 (HbA1c) $\geq 6.5\%$ ¹

加價[#]至拒絕受保

如客戶為年長糖尿病患者，一切檢查結果正常，核保部有可能考慮給予標準級別。

保費級別根據年齡、控制程度 (糖化血色素 HbA1c)、吸煙習慣、有否按時覆診治療、併發症嚴重程度、其他心血管疾病風險因素及患糖尿病年期而作評估

如要排除糖尿病，客戶需要提供最近的血葡萄糖耐量試驗 (OGTT)。

¹根據美國糖尿聯會的定義

糖尿病 (Diabetes)

核保指引

醫療	
血糖控制良好 及 沒有併發症	加價及不保事項# 至 拒絕受保 視乎遞交的檢查及報告結果 #不保事項：任何因糖尿病及其併發症而引致之有關檢查或治療 包括但不限於缺血性心臟病, 中風及腎衰竭
如客戶為吸煙者，或患有一型糖尿病、 高血壓、蛋白尿、腎功能異常、潰瘍、 糖尿病性視網膜病變、壞疽或截肢史、 腦血管疾病（包括頸動脈狹窄）、 冠狀動脈疾病、周圍血管疾病	拒絕受保
如要排除糖尿病，客戶需要提供最近的血葡萄糖耐量試驗 (OGTT) 。	

妊娠糖尿病 (Gestational DM)

簡介

- 指原先沒有糖尿病症狀的女性，在懷孕時出現高血糖的症狀

病徵

- 多不一定會有明顯症狀，不過會增加妊娠毒血症、憂鬱症的風險，也會提高需剖宮產的可能性
- 若孕婦有妊娠糖尿病，沒有妥善治療，可能會提高嬰兒生長過度、出生後低血糖或黃疸的風險，嚴重的話也可能造成死產，而孩童長大後兒童期肥胖及罹患2型糖尿病的風險也比較高

治療

- 飲食控制或藥物治療

考慮因素

- 嚴重程度
- 有否出現併發症

基本核保要求

- 詳述病況 (產後驗血結果**HBA1c**、空腹血糖**FBS**是否已回復正常)
- 請遞交產後驗血報告 (如有)

妊娠糖尿病（ Gestational DM ）

核保指引	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
生產後血糖回復正常； 沒有糖尿病跡象	標準			
生產後未有康復 或血糖不正常	加價 或 / 及 不保事項* 至 擱置受保 請參閱「糖尿病（ Diabetes ）」基本核保要求			

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

甲狀腺功能亢進症 (Hyperthyroidism)

簡介

- 甲狀腺荷爾蒙水平過高

病徵

- 身體因高代謝狀態而產生之不適
例如怕熱、食量大增、體重下降、心悸、手震、大便次數增加及月經量多等

治療

- 藥物、手術及放射性碘治療

考慮因素

- 治療時期長短、病情是否受到控制、接受治療種類
- 有否出現併發症
- 是否需要定期覆診及長期服用藥物

基本核保要求

- 驗血：游離四碘甲狀腺素 (Free T4)

甲狀腺功能亢進症（Hyperthyroidism）

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
停止治療超過兩年 甲狀腺功能完全正常	標準			
病情受控及 治療三個月以上	標準		不保甲狀腺	標準
未經治療 / 病情未受控 / 甲狀腺功能不正常	擱置受保			

甲狀腺功能減退症 (Hypothyroidism)

簡介

- 甲狀腺荷爾蒙水平過低

病徵

- 身體因低代謝狀態而產生之不適
例如：疲勞、體重增加、髮質脆弱、身體浮腫等等

治療

- 藥物控制

考慮因素

- 如先天性並於早期發現，身體發育是否正常
- 病情是否受到控制及有否出現併發症（如：高血壓、心血管異常等）

基本核保要求

- 驗血：游離四碘甲狀腺素 (Free T4)

甲狀腺功能減退症（Hypothyroidism）

核保指引

核保指引		人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
有足夠治療和病情受控 (如無高血壓或心血管異常)	≤2年	標準		不保甲狀腺	標準
	>2年			標準	
未經治療 / 病情未受控 / 甲狀腺功能不正常		擱置受保			

甲狀腺結節 (Thyroid Nodule)

簡介

- 甲狀腺細胞異常生長，有可能為甲狀腺癌

病徵

- 可能有甲狀腺腫塊及甲狀腺功能亢進情況等

治療

- 手術切除
- 醫學觀察

考慮因素

- 出現甲狀腺結節的年期
- 甲狀腺結節是否已完全切除
- 有否帶有惡性跡象或其他症狀

基本核保要求

- 甲狀腺超聲波 (Ultrasound of Thyroid)
- 如已手術切除，需要提交病理報告 (Pathology Report)

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

甲狀腺結節 (Thyroid Nodule)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
已做甲狀腺結節切除手術； 病理報告為良性； 現時甲狀腺超聲波完全正常	標準			
臨床診斷為 良性甲狀腺結節； 沒有任何可疑超聲波特徵	標準	不保早期甲狀腺癌 及甲狀腺癌	不保事項 ^{1,2}	不保早期甲狀腺癌 及甲狀腺癌
未有接受檢查或 甲狀腺結節性質未明	擱置受保			

¹ 所有醫療產品 (保誠加護一生住院現金儲蓄保險 (ENCASH) 除外)：不保甲狀腺。

² 保誠加護一生住院現金儲蓄保險 (ENCASH) 專屬核保指引：不保 1) 甲狀腺結節，2) 甲狀腺的良性或惡性腫瘤。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

甲狀腺癌 (Thyroid Cancer)

簡介

- 於甲狀腺 (於頸部前面的內分泌組織) 生長的惡性腫瘤。

病徵

- 頸部前端有無痛硬塊、聲音沙啞、頸痛、吞嚥困難、持續咳嗽等。

治療

- 手術治療、放射性碘治療及體外放射治療。

考慮因素

- 癌症T-N-M分期
- 接受過的治療種類
- 痊癒至今相距時間

基本核保要求

- 主診醫生報告 (MAR) 或由客戶遞交醫療報告及病理報告
- 驗身 (Medical Exam)
- 游離四碘甲狀腺素 (Free T4)
- 甲狀腺超聲波 (Ultrasound Thyroid)

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

甲狀腺癌 (Thyroid Cancer)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
一般甲狀腺癌	標準 至 加價	加價 至 不保甲狀腺癌 及早期甲狀腺癌 至 擱置受保 (視乎產品、癌症期數、 康復程度而定)	不保甲狀腺 至 擱置受保	不保早期甲狀腺癌 及甲狀腺癌 至 擱置受保
已轉移之甲狀腺癌 / 未分化癌	拒絕受保			

乳房良性疾病 (Benign Breast Condition)

* 只適用於女性受保人

簡介

- 乳房囊腫 (Breast cyst): 含液體的腫塊，通常為良性
- 纖維腺瘤 (Fibroadenoma): 由纖維或腺體組織形成的一種良性乳房腫瘤
- 乳房纖維囊腫 (Fibroadenosis): 一種良性的乳房變化

病徵

- 乳房疼痛、腫塊、腫脹

治療

- 手術切除
- 醫學觀察

考慮因素

- 囊腫、結節或腫瘤種類及性質
- 曾否進行切除手術、細針抽取細胞檢查或其他活體組織切片

基本核保要求

- 過往之檢查報告 (包括超聲波檢查、乳房 X 光造影檢查)
如未能提供報告，客戶可能須要進行乳房超聲波檢查 – 請參照最新超聲波指引
- 病理報告 (如已做切除手術、細針抽取細胞檢查或其他活體組織切片)

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

乳房良性疾病 (Benign Breast Condition)

* 只適用於女性受保人

核保指引

核保指引		人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
現有乳房疾病					
乳腺良性鈣化 (Breast Benign Calcification) 單純性乳房囊腫 (Simple Breast Cyst) 乳房脂肪瘤 (Breast Lipoma) 乳房纖維腺病 (Fibroadenosis)		標準			
良性乳腺結節 (Benign breast nodule)/ 乳房纖維腺瘤 (Fibroadenoma)		標準	不保乳癌及乳房原位癌	不保事項 ^{1,2}	不保乳癌 及乳房原位癌
其他情況		根據影像報告個別考慮			
乳房疾病已做手術完全切除病理報告證明為良性					
乳房脂肪瘤(Breast Lipoma)		標準			
單純性乳房囊腫 (Simple Breast Cyst)		標準			
乳房纖維腺瘤 (Fibroadenoma)	單純性纖維腺瘤 (無非典型性質)	標準	所有危疾產品 (CIT2除外)：標準 CIT2：+50%	+50% / 不保事項 ^{1,2}	標準
	非單純性纖維腺瘤		不保乳癌及乳房原位癌	不保事項 ^{1,2}	不保乳癌及乳房 原位癌
其他情況		根據病理報告個別考慮			

¹ 所有醫療產品 (保誠加護一生住院現金儲蓄保險 (ENCASH) 除外)：不保乳房。

² 保誠加護一生住院現金儲蓄保險 (ENCASH) 專屬核保指引：不保 1) 乳房結節，2) 乳房纖維腺瘤，3) 乳房的良性或惡性腫瘤。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

乳癌 (Breast Cancer)

* 只適用於女性受保人

簡介

- 於乳房生長的惡性腫瘤

病徵

- 乳房出現塊、腫脹、形狀或大小有改變、持續或不尋常疼痛
- 乳頭形狀改變、有分泌物或皮疹。乳房皮膚變厚、出見皺紋、凹陷、皮疹等

治療

- 手術治療、化療、標靶治療、賀爾蒙治療及放射治療

考慮因素

- 癌症期數
- 接受過的治療種類
- 痊癒至今相距時間

基本核保要求

- 主診醫生報告 (MAR) 或由客戶遞交醫療報告及病理報告

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

乳癌 (Breast Cancer)

* 只適用於女性受保人

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
乳房原位癌 確認沒有入侵性	標準	不保乳癌及 乳房原位癌	不保乳房	不保乳癌及乳房原位癌
第一至三期乳癌	加價 至 擱置受保	加價 及 不保乳癌及乳房原位癌 至 擱置受保	加價 及 不保乳房 至 擱置受保	加價 及 不保乳癌及乳房原位癌 至 擱置受保
第四期乳癌	拒絕受保			

類風濕性關節炎 (Rheumatoid Arthritis)

簡介

- 一種慢性免疫系統疾病，主要影響關節，其次會影響肌肉、心、肺、皮膚、血管、神經等器官

病徵

- 關節疼痛、僵硬、腫大及變形等，患者亦會有全身疲勞等徵狀

治療

- 物理治療、藥物治療、手術治療

考慮因素

嚴重程度

輕度：	外周關節輕微疼痛或僵硬，無腫脹或輕微腫脹，無畸形。無需持續接受治療；物理治療和偶爾使用阿司匹林和抗風濕藥物。能夠進行日常生活的所有正常活動；其他檢查完全正常
中度：	中度疼痛和僵硬，更廣泛的關節受累，受累關節輕微變形或活動受限。需要頻繁或持續的藥物治療。能夠在有限的困難或幫助下執行大部分或所有日常生活的活動。
重度：	慢性活動性疾病，不能完全擺脫疼痛，中度或明顯的畸形，運動嚴重受限和功能受損。需要持續的藥物治療，需要大量額外時間或幫助執行少量日常生活的活動。

基本核保要求

- 驗身 (Medical Exam)
- 驗血：紅血球沉降率 (ESR) 及類風濕因子(RA Factor)

類風濕性關節炎 (Rheumatoid Arthritis)

核保指引	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
病情輕微	標準 至 加價	CIT2：標準	不保類風濕關節炎	加價
		所有危疾產品 (CIT2除外)： 加價 及 不保嚴重類風濕關節炎		
中度病情	加價	所有危疾產品： 加價 及 不保嚴重類風濕關節炎	拒絕受保	
嚴重病情		所有危疾產品：拒絕受保		

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。
* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

銀屑病 (Psoriasis)

簡介

- 俗稱為牛皮癬，是一種慢性皮膚病。
- 銀屑病的發病原因較為複雜，與先天的基因遺傳和後天環境因素有關。
- 銀屑病的兩個發病高峰期，分別是10歲至20歲和40至50歲兩個階段，而且銀屑病會在許多部位上發作，其中，頭皮指甲位難醫治。

病徵

- 手肘、膝蓋及腰間主要表現為出現紅色或深紅色的斑塊，表面會有灰白色或者灰黃色的鱗屑；
- 在頭皮上呈現紅斑，早期出現在髮腳的位置，十分容易產生頭皮屑。
- 銀屑病還會影響關節，患者的關節會出現紅腫、發炎、晨僵等病症，導致關節無法正常活動，與類風濕關節炎很相似，有機會致使關節腐蝕，令關節永久變形。

治療

- 外用藥物治療、口服藥物治療、光學療法、生物製劑

考慮因素

- 嚴重程度
- 有沒有關節變形
- 治療方法

基本核保要求

- 詳述病況
- 驗身 (Medical Exam) / 視像驗身 (Tele-Medical Exam) (適用於特選客戶)

銀屑病 (Psoriasis)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾 [#]	醫療	癌病
<u>輕微</u> 只需接受局部治療 或 外用藥物治療	標準	標準	標準	標準
<u>中度</u> 需要接受外用類固醇藥物治療			不保銀屑病	
<u>嚴重</u> 需要接受 照光治療 及/或 系統性藥物治療 及/或 免疫調節劑治療	加價	加價	拒絕受保	

[#] 如投保「誠保一生」危疾保 (CIM3)，兒童保障有機會不保嚴重銀屑病。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

腦部 / 精神疾病、
眼睛疾病、
骨骼 / 關節 / 皮膚
疾病

腦部 / 精神疾病

1. 抑鬱症
2. 焦慮症
3. 泌乳素瘤



眼睛疾病

1. 白內障
2. 青光眼
3. 視網膜脫落

骨骼 / 關節 / 皮膚 疾病

1. 退化性關節炎
2. 椎間盤突出
3. 痛風
4. 脊椎側彎
5. 濕疹 / 皮炎

抑鬱症 (Depression)

簡介

- 一種腦部疾病，是由於體內產生過量壓力荷爾蒙，從而破壞了腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位

病徵

- 持續情緒低落、對事物失去興趣及動力、難以熟睡、身心遲滯及認知功能下降等

治療

- 心理治療、藥物治療

考慮因素

- 現有病徵及治療方法
- 覆診頻率及上一次病發時間
- 有否因抑鬱症住院；或曾有自殺行為或自殺念頭
- 有否申請病假或有否其他精神病

基本核保要求

- 驗身 (Medical Exam) 由醫務部醫生進行
- 主診醫生報告 (MAR) (如有須要)

抑鬱症 (Depression)

核保指引

	人壽	危疾	早期危疾	醫療	癌症
已痊癒並完成治療 無須服藥或覆診；無 影響日常生活	標準	不保 嚴重精神病		痊癒並完成治療少於 1 年：擱置受保	標準
				痊癒並完成治療痊癒 1-5 年：不保精神病	
				痊癒並完成治療痊癒超過 5 年：標準	
有其他精神病 或帶有其他徵狀 / 自殺記錄	加價 至 拒絕受保		加價、 不保嚴重精神病 至 拒絕受保	拒絕受保	

焦慮症 (Anxiety)

簡介

- 主要分為廣泛性焦慮症和恐懼症，特點會過度地擔憂和預期危險即將發生

病徵

- 思想上會有過多的擔憂及預期會有逼切而又不能避免的危險發生
- 生理反應會有心跳呼吸加速、胸部與腹部不適、肌肉緊張、口乾、出汗等

治療

- 心理治療、藥物治療

考慮因素

- 現有病徵及治療方法
- 覆診頻率及上一次病發時間
- 有否因焦慮症住院；或曾有自殺行為或自殺念頭
- 有否申請病假或有否其他精神病

基本核保要求

- 驗身 (Medical Exam) 由醫務部醫生進行
- 主診醫生報告 (MAR) (如有須要)

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

焦慮症 (Anxiety)

核保指引

	人壽	危疾	早期危疾	醫療	癌症
已痊癒並完成治療 無須服藥或覆診； 無影響日常生活	標準	不保嚴重精神病		痊癒並完成治療少於 1 年：擱置受保	標準
				痊癒並完成治療痊癒 1-5 年：不保精神病	
				痊癒並完成治療痊癒超過 5 年：標準	
有其他精神病 或帶有其他徵狀 / 自殺記錄	加價 至 拒絕受保		加價、 不保嚴重精神病 至 拒絕受保	拒絕受保	

泌乳素瘤 (Prolactinoma)

簡介

- 身體內的泌乳素 (催乳素) 過高。原因之一是泌乳素瘤，即腦下垂體前葉的細胞腫瘤分泌過多的泌乳素

病徵

- 可有閉經、溢乳、不育等
- 較大的泌乳素瘤可有腫瘤壓迫病徵如視交叉綜合症

治療

- 藥物治療、手術治療或放射性治療

考慮因素

- 微腺瘤 (小於10毫米) 或大腺瘤 (大於10毫米)
- 曾接受治療種類
- 有否垂體功能減退

基本核保要求

- 驗身 (Medical Exam)
- 驗血：泌乳素 (Prolactin)
- 提供腦部 / 腦下垂體磁力共振報告

泌乳素瘤 (Prolactinoma)

核保指引

		人壽	危疾 / 早期危疾	醫療	癌症
高催乳素血症, 沒有找到原因 或未切除微腺瘤/泌乳素瘤(≤ 10mm), 垂體窩正常, 沒有皮質類固醇替代治療		標準	所有危疾產品 (CIT2除外) : 不保 腦下垂體腫瘤切除手術 CIT2 : 標準	不保 腦下垂體	標準
皮質類固醇替代治療的後遺垂體機能減退		加價	所有危疾產品 (CIT2除外) : 加價 及不保腦下垂體腫瘤切除手術 CIT2 : 加價	個別考量	加價
腺瘤/泌乳素瘤 (> 10mm) / 大腺瘤 手術性治療, 完全康復 並沒有 併發症及沒有復發	治療後康復 ≤ 6個月	拒絕受保			
	治療後康復 > 6個月		標準	不保 腦下垂體	標準

白內障 (Cataract)

簡介

- 眼球中的晶體混濁或不透光，受影響的眼睛會慢慢惡化

病徵

- 視力下降；看燈光時周圍有光暈及感到刺眼

治療

- 晶體摘除手術

考慮因素

- 病發日期
- 眼疾的種類及治療
- 目前的視力狀況

基本核保要求

- 詳述病發情況、檢查結果、治療情況、是否已進行手術及併發症

白內障 (Cataract)

核保指引

	人壽	危疾	早期危疾	醫療	癌症
進行手術 > 1 年 視力正常	標準				
進行手術 ≤ 1 年 視力正常	標準			不保白內障	標準
沒有進行手術 / 其他情況	標準	不保失明	不保單眼失明		

青光眼 (Glaucoma)

簡介

- 眼球內壓力過高，導致視覺神經萎縮，損傷以致永久性的失明

病徵

- 無症狀、視力模糊、頭痛、眼痛、無痛性喪失視力

治療

- 手術治療、口服藥物

考慮因素

- 病發日期
- 眼疾的種類及治療
- 目前的視力狀況

基本核保要求

- 詳述病發情況、檢查結果、治療情況、是否已進行手術及併發症

青光眼 (Glaucoma)

核保指引

	人壽	危疾	早期危疾	醫療	癌症
已進行手術治療； 視力正常； 完全康復及沒有復發	標準			不保眼睛	標準
視力欠佳； 正接受藥物治療	標準	不保失明	不保單眼失明		

視網膜脫落 (Retinal Detachment)

簡介

- 當視網膜內層與上皮之間形成缺口會導致部分或全部視網膜脫落

病徵

- 無症狀、視力模糊、頭痛、眼痛、無痛性喪失視力

治療

- 手術治療、激光凝固

考慮因素

- 病發日期
- 眼疾的種類及治療
- 目前的視力狀況

基本核保要求

- 詳述病發情況、檢查結果、治療情況、是否已進行手術及併發症

視網膜脫落 (Retinal Detachment)

核保指引

	人壽	危疾	早期危疾	醫療	癌症
已治療； 沒有任何併發症及視力正常	標準	不保失明	不保單眼失明	不保眼睛	標準
沒有進行治療					

退化性關節炎 (Osteoarthritis)

簡介

- 關節軟骨的持續性磨損，引致關節腔變窄以及骨刺的產生

病徵

- 關節疼痛、僵硬、腫大及變形等

治療

- 減輕體重、鎮痛藥物、手術治療

考慮因素

- 受影響關節位置
- 是否有關節變形情況及是否需要用輔助儀器
- 現時病徵、功能狀態、治療方案

基本核保要求

- 詳述病發情況、治療、檢查結果及併發症
- 如有任何徵狀：

驗身 (Medical Exam)

退化性關節炎 (Osteoarthritis)

核保指引	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
輕微病情	標準	標準	加價 至 不保關節炎	標準
中度病情			不保關節炎	
嚴重病情	標準 至 加價		拒絕受保	

椎間盤突出 (Prolapsed Intervertebral Disc)

簡介

- 脊椎兩節骨中間的啫喱狀軟骨組織突出，從而壓擠到脊椎神經

病徵

- 腰背痛及麻痺等。如腰椎間盤突出，背痛可以擴散至股部、腿部或蔓延至腳部

治療

- 藥物治療、物理治療、手術治療及其他治療如針灸等

考慮因素

- 職業
- 嚴重程度
- 曾接受治療種類
- 有否因為椎間盤突出而請病假及病假日數案

基本核保要求

- 詳述病發情況（嚴重程度、有否影響日常生活、病假日數）、治療及檢查結果

椎間盤突出 (Prolapsed Intervertebral Disc)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
病情輕微	標準	標準	不保受影響脊椎	標準
持續腰背痛； 需長期治療及日常生活受影響		不保癱瘓及失去獨立生活能力		
曾做手術		標準 至 不保癱瘓及失去獨立生活能力 (視乎病情)		

痛風 (Gout)

簡介

- 體內累積了過多的尿酸而引發之關節炎

病徵

- 關節 (通常是大腳趾) 疼痛、腫脹、發紅、發熱及關節僵直

治療

- 藥物治療

考慮因素

- 血液尿酸含量
- 痛風次數及頻率
- 是否有多個關節受影響或有否關節變形

基本核保要求

- 詳述病發情況、治療、檢查結果及併發症

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

痛風 (Gout)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
高尿酸血症 沒有痛風病史 / 有輕微痛風	標準			
中度痛風	標準	加價	不保痛風	標準
嚴重痛風	加價		拒絕受保	

脊椎側彎 (Spinal Curvature)

簡介

- 脊柱側彎是指人的脊椎側向傾斜, 大約 3% 的人會有脊椎側彎的問題。如情況嚴重，有可能會引致呼吸困難，及對懷孕造成障礙

治療

- 治療方式會依脊椎側彎的程度、位置及病因而有不同，輕微的脊椎側彎只需要定期觀察，中度與嚴重的個案或需配戴背架及手術治療直

考慮因素

- 嚴重程度
輕度：步態正常，可見畸形極少，無內部器官功能損害，無肺功能檢查異常
中度：畸形更為突出，部分活動受限但功能容量尚可，無內部器官功能損害，肺功能檢查正常
重度：步態受損，明顯畸形伴心肺功能損害，肺功能檢查異常（存在肺部限制性缺陷的臨床依據）

基本核保要求

- 詳述脊椎側彎的程度及有否進行手術等病況
- 如病歷不全：
驗身 (Medical Exam)

脊椎側彎 (Spinal Curvature)

核保指引		人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
未有進行手術	輕度胸部畸形	標準			
	中度胸部畸形	標準		不保脊椎側彎	標準
	嚴重胸部畸形 或存在併發症	加價 至 拒絕受保	加價 至 拒絕受保	拒絕受保	
已接受手術並痊癒； 沒有任何後遺症 （如呼吸困難、 活動能力受阻等）	少於一年	加價	拒絕受保		
	一年至五年	標準		不保脊椎側彎	
	多於五年			標準	
已接受手術 但未有完全康復		加價 至 拒絕受保	拒絕受保		

濕疹 / 皮炎 (Eczema / Dermatitis)

簡介

- 皮炎是常見皮膚刺激的總稱。這種疾病有三種常見類型：特應性皮炎（濕疹）、脂溢性皮炎和接觸性皮炎。

病徵

- 發癢、皮膚乾燥或皮疹
- 皮膚起泡、滲出、結痂或剝落

治療

- 經常保濕有助於控制症狀。治療方法還可包括使用含藥油膏劑、乳膏劑和洗髮劑。

考慮因素

- 成因
- 嚴重程度
- 有沒有影響日常生活
- 治療方法

基本核保要求

- 詳述病況
- 驗身 (Medical Exam) / 視像驗身 (Tele-Medical Exam) (適用於特選客戶)

濕疹 / 皮炎 (Eczema / Dermatitis)

核保指引

		人壽	早期危疾 / 危疾 [#]	醫療	癌病
濕疹 / 過敏性皮炎		標準	標準	標準	標準
剝落性皮炎， 成因未明	未完全康復 / 完全康復 < 6個月	標準	標準	擱置受保	標準
	已完全康復 ≥ 6個月	標準	標準	不保皮炎或濕疹	標準

[#] 如投保「誠保一生」危疾保 (CIM3)，兒童保障有機會不保嚴重濕疹。

^{*} 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

呼吸系統疾病、
血管血液疾病、
肝 / 膽疾病



呼吸系統疾病

1. 哮喘
2. 睡眠窒息症
3. 2019 冠狀病毒病 (COVID-19)
4. 肺炎
5. 肺結節

血管血液疾病

1. 中風
2. 短暫性腦缺血發作
3. 地中海貧血

肝 / 膽疾病

1. 甲型肝炎
2. 乙型肝炎
3. 脂肪肝
4. 肝血管瘤
5. 膽石
6. 膽囊息肉

哮喘 (Asthma)

簡介

- 一種支氣管過敏的毛病，患者很容易受外來物體的刺激而引致支氣管收縮
- 主要特徵是多變和復發的症狀、可逆性氣流阻塞及支氣管痙攣

病徵

- 哮喘病徵包括喘息、咳嗽、胸腔緊迫、胸悶及呼吸困難

治療

- 吸入性藥物或根據嚴重程度使用口服藥物

考慮因素

- 是否有吸煙習慣
- 最近一次病發至今相距年期
- 病情嚴重程度及病發頻率
- 接受治療種類及考慮是否需要定期覆診或長期使用氣管舒張劑

基本核保要求

- 哮喘問卷 (Asthma Questionnaire)

哮喘 (Asthma) * 只適用於18歲以下受保人

核保指引		人壽	早期危疾 / 危疾 [#]	醫療	癌症
≤ 2歲		個別考慮			標準
>2歲 至 ≤ 5歲， 被確診>1年	間歇性	標準	不保嚴重哮喘 [#]	標準	
	輕微	加價		不保事項 ¹	
	中度		加價 及 不保嚴重哮喘 [#]		
	嚴重	拒絕受保			
>5歲 至 < 18歲， 被確診>1年	間歇性	標準	不保嚴重哮喘 [#]	標準	
	輕微			不保事項 ¹	
	中度	標準 至 加價	加價 及 不保嚴重哮喘 [#]		
	嚴重	拒絕受保			

¹ 不保事項：哮喘、支氣管炎、慢性阻塞性肺病。

[#] 如投保「誠保一生」危疾保，兒童保障有機會不保嚴重哮喘、次級嚴重哮喘。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

哮喘 (Asthma) * 只適用於成年受保人

核保指引	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
非吸煙人士； 最近發病至今 > 2年 或完全康復	標準			
輕度哮喘	標準	標準 至 加價	加價 至 不保事項 ¹	標準
中度哮喘	加價		不保事項 ¹	
重度哮喘	加價 至 拒絕受保		拒絕受保	

¹ 不保事項：哮喘、支氣管炎、慢性阻塞性肺病。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

睡眠窒息症 (Obstructive Sleep Apnea)

簡介

病徵

- 在睡覺期間，持續出現及間斷有呼吸停頓的情況
- 白天嗜睡、打鼻鼾、焦躁不安、難以熟睡、疲倦、抑鬱、高血壓等

治療

- 減肥、避免飲酒、使用鎮靜劑、口服藥物
- 使用正壓呼吸輔助器 (例如：CPAP)
- 雷射懸雍垂腭咽整型術或以外科手術改善呼吸道阻塞

考慮因素

- 徵狀、對治療的反應、身體機能
- 有否使用正壓呼吸輔助器 (例如：CPAP)
- 呼吸不足指數 (AHI) 或睡眠呼吸障礙指數 (RDI)
- 血液含氧量及氧氣飽和度

基本核保要求

- 遞交睡眠測試報告

睡眠窒息症 (Obstructive Sleep Apnea)

定義

	輕度 至 中度	嚴重
症狀/對治療的反應	治療反應滿意 但仍會出現白天嗜睡	持續出現白天嗜睡徵狀
身體機能	個性沒有改變 沒有影響工作或社交生活	有證據顯示影響工作能力 同時出現功能障礙如焦慮及抑鬱
呼吸不足指數 (AHI) / 睡眠呼吸障礙指數 (RDI)	10 - 30	高於 30
血含氧量	一般超過80% 亦有可能會降低至超過60% 在睡眠時反覆缺氧； 而睡醒時能回到基本水平	可能低於60% 窒息之間可能會出現長期缺氧

睡眠窒息症 (Obstructive Sleep Apnea)

核保指引		人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
未有治療	輕度	標準	所有危疾產品 (CIT2除外) : 加價 及 不保嚴重阻塞性睡眠窒息症 CIT2 : 標準	加價 或 不保阻塞性睡眠窒息症#	標準
	中度	標準 至 加價	所有危疾產品 (CIT2除外) : 加價 及 不保嚴重阻塞性睡眠窒息症 CIT2 : 加價	拒絕受保	
	嚴重	加價			
已接受治療 或正在治療 且進展良好	初次診斷 ; 輕度	標準	所有危疾產品 (CIT2除外) : 不保嚴重阻塞性睡眠窒息症 CIT2 : 標準	加價 或 不保阻塞性睡眠窒息症#	
	初次診斷 ; 中度			拒絕受保	
	初次診斷 ; 嚴重	標準 至 加價	所有危疾產品 (CIT2除外) : 不保嚴重阻塞性睡眠窒息症 CIT2 : 加價		

[#] 如受保人擁有其他心血管風險因素，可能拒絕受保。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

2019冠狀病毒病（COVID-19）

簡介

- 「2019冠狀病毒病」是由一種名為嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2的新型冠狀病毒引起的疾病。

病徵

- 最常見病徵包括發燒、乾咳及感到疲乏。其他病徵包括喪失味覺或嗅覺、鼻塞、結膜炎、喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛、皮疹、噁心或嘔吐、腹瀉、發冷或暈眩。有些受感染者只有很輕微或不明顯的病徵，有些則可能出現嚴重的徵狀，例如呼吸困難、胸口痛或精神混亂等。

治療

- 治療包括支持性護理以緩解症狀和預防並發症。這包括補充氧氣、補液、皮質類固醇和鎮痛藥。

考慮因素

- 有沒有接受住院治療
- 患者本身的健康狀況

基本核保要求

- 2019冠狀病毒病 問卷 (PIL – UI000016)
- 主診醫生報告 (MAR)
- 驗身 (Medical Exam) (如需要)

* 由於2019冠狀病毒病不斷變化，核保要求可能會不時更新。

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

2019冠狀病毒病 (COVID-19)

核保指引

核保指引		人壽 / 癌症	早期危疾 / 危疾	醫療
有2019冠狀病毒病相關症狀或 2019冠狀病毒病檢測結果 ¹ 陽性(確診者)	沒有需要入院治療:			
	未完全康復	擱置受保		
	已完全康復，無併發症，恢復正常的身體功能和活動	標準 ²		
	需要接受入院治療:			
	普通病房(未入住ICU, ITU) 所有症狀已經痊癒，無併發症，恢復正常的身體功能和活動：	完全康復 ≤ 1個月：擱置受保		
		完全康復 > 1個月：視乎主診醫生報告*		
	加護病房(ICU), 重症治療病房(ITU) 所有症狀已經痊癒，無併發症，恢復正常的身體功能和活動：	完全康復 ≤ 6個月：擱置受保		
		完全康復 > 6個月：視乎主診醫生報告*		

¹ 2019冠狀病毒病檢測包括核酸檢測 或 快速抗原檢測。

² 公司將根據客戶於投保書 及 2019冠狀病毒病問卷上的申報作核保。

* 核保決定將基於是否存在併發症 / 後遺症。

* 由於2019冠狀病毒病不斷變化，因此核保要求可能會不時更新。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

肺炎 (Pneumonia)

簡介

- 肺炎是由細菌、病毒、真菌或寄生蟲引致的肺部感染。
- 肺炎會阻礙肺部的正常換氣過程，使血液中的含氧量降低，令人體難以排出二氧化碳。
- 病者感染後病情可能輕微，但亦可能危及生命甚至致命。在香港，肺炎仍然十分常見，我們必須留意抗藥性的問題。

病徵

- 皮膚、嘴唇、舌頭和手指因缺氧而呈青紫色
- 呼吸困難和喘鳴
- 呼吸和咳嗽時胸痛
- 咳嗽
- 痰呈綠色或黃色
- 發燒和發冷

治療

- 治療細菌性肺炎的抗生素
- 治療病毒性肺炎的抗病毒藥物
- 嚴重的肺炎患者可能需要住院以接受靜脈抗生素注射、氧氣供應和密切監察
- 服用藥物（可能配合抗生素和抗病毒藥物）以舒緩咳嗽、發燒、胸痛和肌肉疼痛等肺炎症狀
- 充足的臥床休息、健康飲食和補充大量水份

考慮因素

- 成因
- 康復程度
- 有沒有併發症

基本核保要求

- 醫療報告
- 驗身 (Medical Exam)

肺炎 (Pneumonia)

核保指引

		人壽	早期危疾 / 危疾 [#]	醫療	癌病
只患上一次，並已完全康復		標準	標準	標準	標準
患上超過一次	未完全康復	標準	標準	擱置受保	標準
	已完全康復	標準	標準	≤2年 個別考慮	標準
				>2年 標準	

[#] 如投保「誠保一生」危疾保 (CIM3)，兒童保障有機會不保肺炎。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

肺結節 (Pulmonary Nodule)

簡介

結節在肺部通常呈圓形「點狀」或「陰影」，密度較一般肺組織為高。從電腦掃描造影中可見肺結節是實性、半實性或磨玻璃樣，以及是否有肺部陷落、肺門淋巴結腫大及胸腔積液等情況。肺結節有可能是早期肺癌。

考慮因素

低風險 – 受保人需要滿足以下所有條件

1. 非吸煙者或戒煙5年或以上
2. 結節邊緣沒有任何不規則或異常
(例如尖刺狀的突起或毛刺)
3. 無肺癌家族史
4. 從未被診斷患上癌症
5. 從未接觸過有害化學物質
6. 肺結節沒有涉及肺上葉

高風險 – 受保人有以下其中一項條件

1. 吸煙者或戒煙不超過5年
2. 結節邊緣形狀不規則或異常
(例如尖刺狀的突起或毛刺)
3. 有肺癌家族史
4. 曾被診斷患上癌症
5. 曾接觸過有害化學物質
6. 肺結節涉及肺上葉

基本核保要求

- 最近期及過往的肺部電腦掃描報告(CT Thorax)

肺結節 (Pulmonary Nodule)

肺結節核保指引分類

所有人壽、危疾、醫療、癌症產品

(不包括PLP2, CIT2, PPM)

- 實性肺結節 - 低風險級別
- 實性肺結節 - 高風險級別
- 半實性(包括磨玻璃)肺結節 - 低風險級別
- 半實性(包括磨玻璃)肺結節 - 高風險級別

PLP2, CIT2

- 實性肺結節 - 低風險級別
- 實性肺結節 - 高風險級別
- 半實性(包括磨玻璃)肺結節 - 所有級別

PPM

- 肺結節 - 所有級別

肺結節 (Pulmonary Nodule)

實性肺結節 – 低風險級別

(風險級別請參考簡介頁內的考慮因素，例如肺結節的位置涉及上肺葉屬於高風險)

結節大小 (mm)	自初次診斷以來的年期	人壽 (PLP2除外)	早期危疾 / 危疾 (CIT2除外)		醫療 (PPM除外)	癌病	
≤ 4	≤ 1 年	標準	受保人≤ 50 歲：	標準	不保事項 ^{1,2}	受保人≤ 50歲：	標準
			受保人>50 歲：	不保肺癌及肺原位癌		受保人>50歲：	不保肺癌及肺原位癌
	> 1 年 及 穩定 (請看註示#)		標準			標準	
> 4 - ≤ 6	≤ 1 年	標準	不保肺癌及肺原位癌		不保事項 ^{1,2}	不保肺癌及肺原位癌	
	> 1 年 及 穩定 (請看註示#)		標準			標準	
> 6 - ≤ 8	≤ 2 年及 穩定 (請看註示#)	加價	不保肺癌及肺原位癌		不保事項 ^{1,2}	不保肺癌及肺原位癌	
	> 2 年及 穩定 (請看註示#)	標準	標準			標準	
> 8	≤ 2 年	擱置受保	擱置受保		擱置受保	擱置受保	
	> 2 - ≤ 3年及 穩定 (請看註示#)	加價	個別考慮		個別考慮	個別考慮	
	> 3 年及 穩定 (請看註示#)	標準	標準		不保事項 ^{1,2}	標準	

需要有至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進，2份報告相隔至少6個月，以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內。

¹ 所有醫療產品 (保誠加護一生住院現金儲蓄保險 (ENCASH) 及「摯為您」優悅醫療保險計劃 除外)：不保肺部。

² 保誠加護一生住院現金儲蓄保險 (ENCASH) 專屬核保指引：不保 1) 肺結節，2) 肺部的良性或惡性腫瘤。

* 以上核保指引是基於肺部電腦掃描結果及沒有肺部感染及/或肺部纖維化的病史。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

肺結節 (Pulmonary Nodule)

適用於美好人生保障計劃 II (PLP2) 及 守護健康危疾定期保II (CIT2/CIT2R)

實性肺結節 - 低風險級				
(風險級別請參考簡介頁內的考慮因素，例如肺結節的位置涉及上肺葉屬於高風險)				
結節大小 (mm)	自初次診斷以來的年期	人壽 (PLP2)		早期危疾 / 危疾 (CIT2/CIT2R)
< 6	≤ 6個月	擱置受保		擱置受保
	>6個月 - ≤ 1 年 及 穩定 (請看註示#)	受保人≤ 50歲：	標準	不保肺癌及肺原位癌
		受保人>50歲：	加價	
	> 1 年及 穩定 (請看註示#)	標準		標準
≥ 6 - ≤ 8	≤ 6個月	擱置受保		擱置受保
	>6個月 - ≤ 2 年 及 穩定 (請看註示#)	加價		不保肺癌及肺原位癌
	> 2 年及 穩定 (請看註示#)	標準		標準
> 8	≤ 2 年	擱置受保		擱置受保
	> 2 - ≤ 3 年 及 穩定 (請看註示#)	標準		不保肺癌及肺原位癌
	> 3 年 及 穩定 (請看註示#)			標準

需要有至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進，2份報告相隔至少6個月，以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內。

* 以上核保指引是基於肺部電腦掃描結果及沒有肺部感染及/或肺部纖維化的病史。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

肺結節 (Pulmonary Nodule)

實性肺結節 - 高風險級別

(風險級別請參考簡介頁內的考慮因素，例如肺結節的位置涉及上肺葉屬於高風險)

結節大小 (mm)	自初次診斷以來的年期	人壽 (PLP2除外)	早期危疾 / 危疾 (CIT2除外)	醫療 (PPM除外)	癌病
≤ 4	≤ 6個月	擱置受保	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 6個月 - ≤ 1年 及 穩定 (請看註示#)	標準	不保肺癌及肺原位癌		不保事項 ^{1,2}
	> 1 - ≤ 2年 及 穩定 (請看註示#)				
	> 2年 及 穩定 (請看註示#)		標準	標準	
> 4 - ≤ 6	≤ 6個月	擱置受保	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 6個月 - ≤ 1年 及 穩定 (請看註示#)	加價	不保肺癌及肺原位癌		不保事項 ^{1,2}
	> 1 - ≤ 2年 及 穩定 (請看註示#)	標準		標準	
	> 2年 及 穩定 (請看註示#)				

需要有至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進，2份報告相隔至少6個月，以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內。

¹ 所有醫療產品 (保誠加護一生住院現金儲蓄保險 (ENCASH) 及「摯為您」優悅醫療保險計劃 除外)：不保肺部。

² 保誠加護一生住院現金儲蓄保險(ENCASH) 專屬核保指引：不保 1) 肺結節，2) 肺部的良性或惡性腫瘤。

* 以上核保指引是基於肺部電腦掃描結果及沒有肺部感染及/或肺部纖維化的病史。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

肺結節 (Pulmonary Nodule)

實性肺結節 - 高風險級別

(風險級別請參考簡介頁內的考慮因素，例如肺結節的位置涉及上肺葉屬於高風險)

結節大小 (mm)	自初次診斷以來的年期	人壽 (PLP2除外)	早期危疾 / 危疾 (CIT2除外)	醫療 (PPM除外)	癌病
> 6 - ≤ 8	≤ 1 年	擱置受保	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 1 - ≤ 2年 及 穩定 (請看註示#)	加價	不保肺癌及肺原位癌		不保事項 ^{1,2}
	> 2 - ≤ 3年 及 穩定 (請看註示#)	標準		標準	
	> 3年 及 穩定 (請看註示#)				
> 8	≤ 3 年	擱置受保	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 3年 及 穩定 (請看註示#)	個別考慮	個別考慮	個別考慮	個別考慮

需要有至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進，2份報告相隔至少6個月，以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內。

¹ 所有醫療產品 (保誠加護一生住院現金儲蓄保險 (ENCASH) 及「摯為您」優悅醫療保險計劃 除外)：不保肺部。

² 保誠加護一生住院現金儲蓄保險(ENCASH) 專屬核保指引：不保 1) 肺結節，2) 肺部的良性或惡性腫瘤。

* 以上核保指引是基於肺部電腦掃描結果及沒有肺部感染及/或肺部纖維化的病史。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

肺結節 (Pulmonary Nodule)

適用於美好人生保障計劃 II (PLP2) 及 守護健康危疾定期保II (CIT2/CIT2R)

實性肺結節 – 高風險級別 (風險級別請參考簡介頁內的考慮因素，例如肺結節的位置涉及上肺葉屬於高風險)			
結節大小 (mm)	自初次診斷以來的年期	人壽 (PLP2)	早期危疾 / 危疾 (CIT2/CIT2R)
< 6	≤ 1 年	擱置受保	擱置受保
	> 1 - ≤ 2年 及 穩定 (請看註示#)	加價	不保肺癌及肺原位癌
	> 2年 及 穩定 (請看註示#)	標準	標準
≥ 6 - ≤ 8	≤ 1 年	擱置受保	擱置受保
	> 1 - ≤ 2年 及 穩定 (請看註示#)	加價	不保肺癌及肺原位癌
	> 2 - ≤ 3年 及 穩定 (請看註示#)	標準	
	> 3年 及 穩定 (請看註示#)		標準
> 8	≤ 3 年	擱置受保	擱置受保
	> 3年 及 穩定 (請看註示#)	個別考慮	個別考慮

需要有至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進，2份報告相隔至少6個月，以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內。

* 以上核保指引是基於肺部電腦掃描結果及沒有肺部感染及/或肺部纖維化的病史。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

肺結節 (Pulmonary Nodule)

半實性(包括磨玻璃)肺結節 - 低風險級別 (風險級別請參考簡介頁內的考慮因素，例如肺結節的位置涉及上肺葉屬於高風險)					
結節大小 (mm)	自初次診斷以來的年期	人壽 (PLP2除外)	早期危疾 / 危疾 (CIT2除外)	醫療 (PPM除外)	癌病
≤ 4	≤ 6個月	擱置受保	擱置受保	擱置受保 不保事項 ^{1,2}	擱置受保
	> 6個月 - ≤ 1年 及 穩定 (請看註示#)	標準	不保肺癌及肺原位癌		不保肺癌及肺原位癌
	> 1年 及 穩定 (請看註示#)				
> 4 - ≤ 6	≤ 6個月	擱置受保	擱置受保	擱置受保 不保事項 ^{1,2}	擱置受保
	> 6個月 - ≤ 1年 及 穩定 (請看註示#)	加價	個別考慮		個別考慮
	> 1年 及 穩定 (請看註示#)	標準	不保肺癌及肺原位癌		不保肺癌及肺原位癌
> 6 - ≤ 8	≤ 1 年	擱置受保	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 1年 及 穩定 (請看註示#)	加價	不保肺癌及肺原位癌	個別考慮	不保肺癌及肺原位癌
> 8	≤ 3 年	擱置受保	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 3年 及 穩定 (請看註示#)	個別考慮	個別考慮	個別考慮	個別考慮

需要有至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進，2份報告相隔至少6個月，以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內。

¹ 所有醫療產品 (保誠加護一生住院現金儲蓄保險 (ENCASH) 及「摯為您」優悅醫療保險計劃 除外)：不保肺部。

² 保誠加護一生住院現金儲蓄保險(ENCASH) 專屬核保指引：不保 1) 肺結節，2) 肺部的良性或惡性腫瘤。

* 以上核保指引是基於肺部電腦掃描結果及沒有肺部感染及/或肺部纖維化的病史。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

肺結節 (Pulmonary Nodule)

半實性(包括磨玻璃)肺結節 - 高風險級別 (風險級別請參考簡介頁內的考慮因素，例如肺結節的位置涉及上肺葉屬於高風險)					
結節大小 (mm)	自初次診斷以來的年期	人壽 (PLP2除外)	早期危疾 / 危疾 (CIT2除外)	醫療 (PPM除外)	癌病
≤ 4	≤ 6個月	擱置受保	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 6個月 - ≤ 1年 及 穩定 (請看註示#)	標準	個別考慮		個別考慮
	> 1年 及 穩定 (請看註示#)		不保肺癌及肺原位癌	不保事項 ^{1,2}	不保肺癌及肺原位癌
> 4 - ≤ 6	≤ 6個月	擱置受保	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 6個月 - ≤ 1年 及 穩定 (請看註示#)	加價	個別考慮		個別考慮
	> 1 - ≤ 5年 及 穩定 (請看註示#)		不保肺癌及肺原位癌	不保事項 ^{1,2}	不保肺癌及肺原位癌
	> 5年 及 穩定 (請看註示#)	標準			
> 6 - ≤ 8	≤ 3年	擱置受保	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 3年 及 穩定 (請看註示#)	加價	不保肺癌及肺原位癌	不保事項 ^{1,2}	不保肺癌及肺原位癌
> 8	≤ 5年	擱置受保	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 5年 及 穩定 (請看註示#)	個別考慮	個別考慮	個別考慮	個別考慮

需要有至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進，2份報告相隔至少6個月，以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內。

¹ 所有醫療產品 (保誠加護一生住院現金儲蓄保險 (ENCASH) 及「摯為您」優悅醫療保險計劃 除外)：不保肺部。

² 保誠加護一生住院現金儲蓄保險(ENCASH) 專屬核保指引：不保 1) 肺結節，2) 肺部的良性或惡性腫瘤。

* 以上核保指引是基於肺部電腦掃描結果及沒有肺部感染及/或肺部纖維化的病史。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

肺結節 (Pulmonary Nodule)

適用於美好人生保障計劃 II (PLP2) 及 守護健康危疾定期保II (CIT2/CIT2R)

適用於只有一粒半實性(包括磨玻璃)肺結節			
結節大小 (mm)	自初次診斷以來的年期	人壽 (PLP2)	早期危疾 / 危疾 (CIT2/CIT2R)
< 6	≤ 1 年	擱置受保	擱置受保
	> 1年 及 穩定 (請看註示#)	標準	個別考慮
≥ 6	≤ 5年 及 穩定 (請看註示#)	加價	不保肺癌及肺原位癌
	> 5年 及 穩定 (請看註示#)	標準	
如超過一粒肺結節 或 結節有變大的趨勢			
需要至少等待超過1年再個別考慮。			

需要有至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進，2份報告相隔至少6個月，以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內。

* 以上核保指引是基於肺部電腦掃描結果及沒有肺部感染及/或肺部纖維化的病史。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

肺結節 (Pulmonary Nodule)

適用於「摯為您」優悅醫療保險計劃 (PPM/PPMR)

適用於只有一粒肺結節		
結節大小 (mm)	自初次診斷以來的年期	醫療 (PPM/PPMR)
≤4	< 2年	擱置受保
	≥ 2年 及 穩定 (請看註示#)	不保肺部
>4	< 3年	擱置受保
	≥ 3年 及 穩定 (請看註示#)	不保肺部
超過一粒肺結節 或 結節有變大的趨勢		
需要至少等待超過5年再個別考慮。		

需要有至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進，2份報告相隔至少6個月，以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內。

* 以上核保指引是基於肺部電腦掃描結果及沒有肺部感染及/或肺部纖維化的病史。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

中風 (Stroke)

簡介

- 任何疾病影響供應到大腦的血管、導致神經系統及 / 或突發性視覺受損超過 24 小時，分為缺血性中風（腦血管栓塞）以及出血性中風（腦出血）

病徵

- 突發性癱瘓、突然喪失一邊或甚至兩邊視力、復視、發音困難、運動失調、眩暈、失語、嚴重頭痛、抽搐及突然喪失知覺

治療

- 藥物控制風險因素，例如高血壓、糖尿病和高脂血症；缺血性中風或需使用抗血小板或抗凝血藥以減低復發機會
- 停止吸煙、控制體重、視乎中風的原因以及嚴重性或需要手術治療

考慮因素

- 嚴重程度
- 影響日常生活程度、走路及能否獨立生活
- 認知功能有否受損

基本核保要求

- 驗身 (Medical Exam)
- 主診醫生報告 (MAR)
- 遞交所有檢查報告（包括磁力共振、電腦掃描等）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。
* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

中風 (Stroke)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
發病至今相距 >6個月	加價 至 擱置受保 (保費級別視乎控制程度、 有否按時覆診治療、 併發症嚴重程度)	拒絕受保		標準
發病至今相距 ≤ 6個月	擱置受保			

短暫性腦缺血發作 (TIA)

簡介

- 大腦特定部位的血液供應暫時受到阻礙，致使產生了神經系統的功能障礙；一般持續時間少於 24 小時

病徵

- 短暫的神經症狀

治療

- 藥物控制風險因素，例如高血壓、糖尿病和高脂血症；或需使用抗血小板或抗凝血藥以減低復發機會
- 停止吸煙及控制體重

考慮因素

- 受影響範圍
- 發病至今相距時間

基本核保要求

- 驗身 (Medical Exam)
- 主診醫生報告 (MAR)
- 遞交所有檢查報告（包括磁力共振、電腦掃描等）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

短暫性腦缺血發作 (TIA)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
發病至今相距 >3個月	加價 至 擱置受保 (保費級別視乎控制程度、 有否按時覆診治療、 併發症嚴重程度)	拒絕受保		標準
發病至今相距 ≤ 3個月	擱置受保			

地中海貧血 (Thalassaemia)

簡介

- 一種遺傳疾病，可分為 alpha 和 beta，而跟據病情的嚴重程度再分為輕型、中型至重型地中海貧血。患者的身體不能有效地製造紅血球

病徵

- 短輕型地中海貧血沒有可見病徵
- 中型至重型地中海貧血患者會有不同的貧血病徵：如心跳、頭暈、四肢乏力等

治療

- 輕型地中海貧血通常不需要治療。較嚴重貧血者需定期輸血和接受藥物治療

考慮因素

- 受檢查報告結果
- 曾接受治療種類
- 上次出現徵狀時間

基本核保要求

- 詳述病發情況、治療、檢查結果及併發症

地中海貧血 (Thalassaemia)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
輕度地中海貧血 無需接受任何治療	標準			
嚴重貧血跡象 或嚴重地中海貧血 需要接受治療或跟進	加價 至 拒絕受保		不保貧血 至 拒絕受保	標準

甲型肝炎 (Hepatitis A)

簡介

- 多因進食不潔食物而感染，引致急性肝臟發炎
- 大部份患者能完全康復，並終生免疫

病徵

- 發燒、疲倦、食慾不振、腹瀉、噁心、腹部疼痛及黃疸等

治療

- 支援性治療及休息

考慮因素

- 是否已完全康復及康復至今時間長短

基本核保要求

- 肝炎問卷 (Hepatitis Questionnaire)
- 驗血：肝功能檢測 (Blood Test – Liver Function Test)

甲型肝炎（Hepatitis A）

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
已康復多於六個月	標準			
已康復三至六個月	標準		擱置受保	標準
至今仍未康復； 或已康復少於三個月	擱置受保			

乙型肝炎 (Hepatitis B)

簡介

- 通過母嬰分娩時接觸、血液接觸或性接觸傳播
- 可引起急性肝炎；而小部份成年人及大部份嬰兒之後會成為長期病毒帶菌者
- 嚴重長期乙型肝炎感染者可致肝硬化、甚至肝癌

病徵

- 少部份人會有發燒、食慾減退、噁心、嘔吐、腹痛、眼白變黃等

治療

- 如沒有病徵、而肝炎指數及肝功能正常，慢性乙型肝炎沒有特別治療
- 如指數不正常，有需要抗病毒治療

考慮因素

- 過往及最新驗血及檢查結果
- 是否有任何癥狀、吸煙及飲酒習慣、是否糖尿病患者及有否肝癌家族病史
- 接受治療種類、有否定期覆診及接受任何檢查

基本核保要求

- 肝炎問卷
- 驗血：保誠肝臟檢驗組合 (Pru-liver Profile)

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

乙型肝炎（Hepatitis B）

核保指引

		人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌病
無需用藥	驗血及其他檢查結果完全正常	標準		+ 25% (只適用於新生意投保或於保單行政部申請增加附加保障)	+50%
	驗血或 / 及其他檢查結果不正常	加價 至 拒絕受保			
曾經 / 正在用藥	檢查結果 / 用藥情況 / 過往病史 / 醫療紀錄而定	加價 至 擱置受保			

脂肪肝 (Fatty Liver)

簡介

- 脂肪於肝臟實質組織內沉積
- 多因酗酒、高脂飲食等引致，超重人士相對患脂肪肝風險較高
- 嚴重可演變成肝硬化、甚至肝癌

病徵

- 一般並無病徵，但有些人可能會有右上腹不適、疲倦等徵狀

治療

- 主要透過控制體重、高血糖、血脂及血壓等引致脂肪肝的因素去治療脂肪肝

考慮因素

- 肝功能測試是否正常
- 曾否進行肝臟抽針檢驗
- 肝臟是否出現纖維化現象

基本核保要求

- 驗血：肝功能檢測 (Blood Test – Liver Function Test)
- 驗血：丙種谷氨酰轉胺酶 (Blood Test – GGT)
- 點對點樣本收集服務 (適用於特選客戶)

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

脂肪肝 (Fatty Liver)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
上述驗血結果正常	標準			
上述驗血結果不正常	加價 至 拒絕受保			

肝血管瘤 (Liver Hemangioma)

簡介

- 肝血管瘤是肝內最常見的良性腫瘤，是肝臟內血管不正常增生所形成的的腫瘤
- 通常是一種良性的腫瘤，不會有症狀，更不會惡化成肝癌

病徵

- 肝血管瘤本身是一種良性的腫瘤，通常不會有症狀，除非肝血管瘤很大造成上腹部有鼓脹感狀

治療

- 原則上肝血管瘤並不需要治療，也沒有口服藥物
- 如肝血管瘤長得很大而壓迫了正常的肝臟，就可以考慮做手術切除

考慮因素

- 肝血管瘤的大小及有否接受治療

基本核保要求

- 遞交過往的肝臟超聲波報告作比較
- 肝臟超聲波

肝血管瘤（Liver Hemangioma）

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
確診為肝血管瘤； ≤ 5 厘米	標準			
確診為肝血管瘤； > 5 厘米	標準		個別考慮	標準

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

膽石 (Gallstone)

簡介

- 膽汁的成分起變化而形成結石

病徵

- 上腹痛、噁心等，但亦可沒有徵狀

治療

- 醫學觀察或手術切除

考慮因素

- 上一次出現病徵是甚麼時候
- 有否做手術或其他治療及有否併發症

基本核保要求

- 詳述病發情況、治療、檢查結果及併發症

膽石 (Gallstone)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
已做手術切除； 痊癒 > 3 個月	標準			
已做手術切除； 痊癒 < 3 個月	擱置受保			標準
沒有治療； 沒有任何徵狀				
	標準		不保膽囊及膽管	

膽囊息肉 (Gall bladder polyp)

簡介

- 膽囊壁的息肉樣病變

病徵

- 大多沒有徵狀，小部份病人有上腹痛

治療

- 醫學觀察或手術切除

考慮因素

- 病徵
- 膽囊息肉大小及考慮體積有否增大
- 有否做手術或其他治療

基本核保要求

- 詳述病發情況、治療、檢查結果及併發症
- 提供膽囊超聲波報告（如已手術切除，需要提交病理報告 (Pathology Report) ）

膽囊息肉 (Gall bladder polyp)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
息肉 < 10毫米而體積穩定； 無需治療； 6 個月內沒有任何徵狀	標準		不保膽囊及膽管	標準
其他情況	擱置受保			



心臟疾病

1. 二尖瓣反流
2. 三尖瓣反流
3. 竇性心律不齊
4. 竇性心律過緩
5. 心房間隔缺損
6. 心室間隔缺損
7. 冠狀動脈性心臟病

二尖瓣反流 (Mitral Regurgitation)

簡介

- 心臟二尖瓣在心室收縮期間無法完全閉合的現象，導致左心室的血液經二尖瓣逆流至左心房內，為最常見的瓣膜性心臟病

病徵

- 二尖瓣閉鎖不全的症狀隨病情而異
- 較嚴重的症狀包含呼吸困難、肺水腫、端坐呼吸，以及陣發性夜間呼吸困難

治療

- 手術治療

考慮因素

- 投保人年齡
- 嚴重程度及有否其他心臟疾病

基本核保要求

- 遞交過往的心臟超聲波報告
- 心臟超聲波（如客戶最近期的心臟超聲波報告已超過 12 個月）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

二尖瓣反流 (Mitral Regurgitation)

核保指引

核保指引	人壽	危疾	早期危疾	醫療	癌症
微量(Trivial) 二尖瓣反流； 沒有其他心臟、心瓣、心血管問題	標準				
輕度(Mild) 二尖瓣反流； 沒有其他心臟、心瓣、心血管問題	標準 至 加價	加價 及 不保心瓣及 結構性手術	加價 及 不保經皮穿刺 心瓣膜手術	不保心瓣	標準
中度 (Moderate) 至 嚴重 (Severe) 二尖瓣反流	加價 至 拒絕受保	拒絕受保			
曾經接受心瓣手術					

三尖瓣反流 (Tricuspid Regurgitation)

簡介

- 三尖瓣反流是由於三尖瓣關閉不全引起

病徵

- 較嚴重者可有疲乏、胃納不佳、肝區脹痛、腹部膨脹和下肢水腫等

治療

- 少量返流可不予理會，但重度的返流需要手術治療

考慮因素

- 受保人年齡
- 嚴重程度及有否其他心臟疾病

基本核保要求

- 遞交過往的心臟超聲波報告
- 心臟超聲波（如客戶最近期的心臟超聲波報告已超過 12 個月）

三尖瓣反流 (Tricuspid Regurgitation)

核保指引	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
微量 (Trivial) 三尖瓣反流 ; 沒有其他心臟、心瓣、心血管問題	標準	標準	標準	標準
輕度 (Mild) 三尖瓣反流 ; 沒有其他心臟、心瓣、心血管問題			不保心瓣	
中度 (Moderate) 三尖瓣反流 ; 沒有其他心臟、心瓣、心血管問題	加價 至 拒絕受保	拒絕受保		標準
嚴重 (Severe) 三尖瓣反流				
曾經接受心瓣手術				

竇性心律不齊 (Sinus Arrhythmia)

簡介

- 吸氣過程中的心臟超速，是為常見的生理現象，並沒有病徵

病徵

- 不需要治療

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
於體檢中發現 沒有任何徵狀	標準			

竇性心律過緩 (Sinus bradycardia)

簡介

- 竇性心率為一般人的正常心率，而正常心率大概是在每分鐘 60 – 100 下內
- 每分鐘心率低於 60 下但頻率無任何異常，便會稱為竇性心率過緩
- 常見於年輕人，無任何徵狀時不屬於病態，但其他相關疾病或藥物也可引致心律過緩，嚴重者可出現併發症

治療

- 如心率不低於每分鐘 50 次，無症狀者無需治療，嚴重者則需要找出病因

考慮因素

- 受竇性心律過緩成因
- 每分鐘脈搏率
- 是否帶有心血管疾病或任何症狀

基本核保要求

- 最近一年的心電圖
- 其他心臟檢查項目 (如有)

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

竇性心律過緩 (Sinus bradycardia)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
沒有其他心血管疾病及 沒有任何症狀 [#] ； 每分鐘脈搏率 ≥ 45	標準			
帶有症狀 [#] 或帶有其他 心血管疾病；或每分鐘 脈搏率 < 45	個別考慮 (視乎病因、症狀、每分鐘脈搏率、血壓等)			

[#] 常見症狀如心絞痛、惡性室性心律失常、心功能不全、暈厥等等

^{*} 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

心房間隔缺損 (ASD)

簡介

- 心房間隔出現一個或多個孔洞

病徵

- 較細小的心房間隔缺損可以沒有病徵
- 較大的心房間隔缺損可致心臟雜音及心力衰竭

治療

- 細小的缺損可能會自然閉合，較大的可手術或介入性導管治療

考慮因素

- 投保時受保人年紀及有否其他先天性疾病
- 心臟功能容量
- 曾接受治療種類（自然閉合 / 手術修補）

基本核保要求

- 提供心臟超聲波報告
- 驗身 (Medical Exam)
- 主診醫生報告 (MAR) （如有須要）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

心房間隔缺損 (ASD)

核保指引

(只適用於新生意投保)

核保指引 (只適用於新生意投保)		人壽		早期危疾 / 危疾		醫療	癌症
		18 – 40 歲	> 40 歲	18 – 40 歲	> 40 歲		
未做手術	微量	標準		加價	標準	不保心臟	標準
	輕度	加價	加價 *60歲後考慮標準	拒絕受保	加價 *60歲後考慮標準	拒絕受保	
	中度		加價	拒絕受保	加價		
	嚴重	拒絕受保					
已做手術； 沒有併發症； 最新心臟超聲波報告 證明無後遺症		完成手術 ≤ 6個月： 擱置受保		完成手術 ≤ 1年： 擱置受保		完成手術 ≤ 3年： 擱置受保	
		完成手術 > 6個月： 標準		完成手術 > 1年： 可考慮標準		完成手術 > 3年： 可考慮標準	

心室間隔缺損（VSD）

簡介

- 心室間隔出現一個或多個孔洞

病徵

- 細小的心室間隔缺損可以沒有病徵；較大的心房間隔缺損可致心臟雜音心力衰竭
- 嬰兒患者會有氣喘、出汗、進食困難和體重增長緩慢的清況

治療

- 細小的缺損可能會自然閉合，較大的可手術或介入性導管治療

考慮因素

- 投保時受保人年紀及有否其他先天性疾病
- 心臟功能容量
- 曾接受治療種類（自然閉合 / 手術修補）

基本核保要求

- 提供心臟超聲波報告
- 驗身 (Medical Exam)
- 主診醫生報告 (MAR)（如有須要）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

心室間隔缺損 (VSD)

核保指引

(只適用於新生意投保)

核保指引 (只適用於新生意投保)		人壽		早期危疾 / 危疾		醫療	癌症
		18 – 40 歲	> 40 歲	18 – 40 歲	> 40 歲		
未做手術	微量	加價	標準	加價		不保心臟	標準
	輕度			拒絕受保			
	中度		加價	拒絕受保	加價	拒絕受保	
	嚴重	拒絕受保					
已做手術； 沒有併發症； 最新心臟超聲波報告 證明無後遺症		完成手術 ≤ 6個月： 擱置受保				完成手術 < 3年： 擱置受保	
		完成手術>6個月： 標準		完成手術 > 6個月： 可考慮標準		完成手術 ≥ 3年： 可考慮標準	

冠狀動脈性心臟病 (Coronary Artery Disease)

簡介

- 冠狀動脈循環未能提供足夠的血流量運送氧氣及營養到心臟過緩，嚴重者可出現併發症

病徵

- 非典型胸痛；心絞痛；疲勞；呼吸困難；暈厥；心律失常；心肌梗塞；急性充血性心臟衰竭

治療

- 細冠狀動脈搭橋術、經皮穿腔冠狀動脈血管置入支架成形術（俗稱通波仔）
- 控制其他因素：如高脂血症、高血壓、糖尿病、吸煙、體重等導致的心臟病

考慮因素

- 受影響之血管以及其嚴重程度

基本核保要求

- 驗身 (Medical Exam)
- 主診醫生報告 (MAR)
- 遞交過往所有有關檢查報告（如心導管及冠狀動脈造影檢查、心臟超聲波、運動心電圖）
- 靜態心電圖 (ECG)（如有須要）

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

冠狀動脈性心臟病 (Coronary Artery Disease)

核保指引

核保指引		人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
發病於40 歲以上	發病至今相距 > 1 個月	加價 至 擱置受保 保費級別視乎控制程度、 有否按時覆診治療、 併發症嚴重程度	拒絕受保		標準 至 加價 保費級別視乎吸煙習慣、 有沒有其他心血管風險問題 (如糖尿病)、家族病史 等
	發病至今相距 ≤ 1 個月	拒絕受保			
發病於40 歲或以下		拒絕受保			



消化系統疾病

1. 胃炎
2. 腸化生
3. 胃食道反流
4. 消化性潰瘍
5. 痔瘡
6. 結腸癌
7. 結腸憩肉
8. 幽門螺桿菌感染

胃炎 (Gastritis)

簡介

- 胃部胃黏膜出現發炎的跡象，可分為急性與慢性

病徵

- 消化不良、胃灼熱、上腹痛、食慾不振

治療

- 藥物治療

考慮因素

- 胃鏡檢查 / 活組織檢查結果
- 是否由酒精引致
- 嚴重程度
- 引致的症狀或併發症種類

基本核保要求

- 遞交「消化系統問卷」(Digestion Questionnaire)
- 如曾接受胃鏡檢查 / 活組織檢查，須遞交報告
- 如情況嚴重，或須索取主診醫生報告 (MAR) 或體檢 (Medical Exam)

胃炎 (Gastritis)

* 只適用於一至二次胃炎病發

核保指引

核保指引			人壽	早期危疾 / 危疾	醫療		癌症
於過去 5 年一至二次病發， 沒有做胃鏡及活檢，沒有幽門螺旋桿菌， 並已完全康復。			標準		最後一次症狀 ≤1年	不保胃炎	標準
					最後一次症狀 >1年	標準	
曾於胃鏡或 活檢中發現	只發現輕微胃炎，沒有其他異常		標準				
	幽門螺旋桿菌	已接受治療	標準				
		沒有治療	標準	不保 胃癌及胃原位癌		不保胃	不保 胃癌及胃原位癌
	腸化生		請參閱「腸化生（ Intestinal Metaplasia ）」				
曾於呼氣測試中發現幽門螺旋桿菌			請參閱「幽門螺桿菌感染（ Helicobacter pylori ）」				

腸化生 (Intestinal Metaplasia)

簡介

- 當胃部細胞發生異常改變，變得像腸道細胞時，就是所謂的腸上皮化生，亦稱為腸化生。
- 腸上皮化生是指胃壁長出腸細胞。原本正常的胃細胞因慢性發炎而受損，在修復受損細胞的過程當中，有機會導致基因病變，結果有些細胞會轉變成腸細胞。腸化生的確切成因不明，不過部份研究顯示它與幽門螺旋菌，遺傳，飲食習慣(高鹽食物，吸煙，酗酒) 和慢性膽汁逆流有關係。

病徵

- 患有腸上皮化生的患者通常沒有明顯的症狀。有些病人可能會出現與其他上消化道疾病相似的徵狀。

治療

- 治療方針在於找出引起慢性胃炎的原因並作出治療，例如幽門螺旋菌，吸煙，酗酒等。飲食的影響需然未有定論，但多吃新鮮蔬果，少吃醃制及煙薰食品總是有益的。

考慮因素

- 成因
- 嚴重程度
- 有沒有幽門螺桿菌感染

基本核保要求

- 胃鏡報告
- 胃部活檢或組織病理報告

腸化生 (Intestinal Metaplasia)

核保指引

		人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌病
輕微至中度 腸化生 ¹	有非典型增生	拒絕受保			
	沒有非典型增生 及 沒有幽門螺桿菌 感染(或曾經受感 染但已完成相關 治療)	標準 ²	不保胃癌、胃原位癌 ²	不保胃 ²	不保胃癌、胃原位癌 ²
嚴重腸化生 ¹		拒絕受保			

¹ 需要遞交胃部活檢或組織病理報告以確認嚴重程度。

² 如有其他胃部的風險因素，需要個別考慮。

* 以上指引只供內部參考，公司將保留最終核保決定權。

胃食道反流 (Gastroesophageal Reflux Disease)

簡介

- 胃下食道括約肌鬆弛，胃酸倒流入食道
- 由於食道的黏膜十分脆弱，若長久受到胃酸刺激會令食道發炎、潰瘍、出血、及出現一種癌前病變的情況

病徵

- 胸口灼痛、胃酸倒流、噯氣及有胃酸的感覺

治療

- 藥改變生活習慣 (如少食多餐、減肥、避免進餐後立即睡覺)
- 藥物治療
- 外科手術

考慮因素

- 胃鏡檢查 / 活組織檢查結果
- 嚴重程度
- 引致的症狀或併發症種類

基本核保要求

- 遞交「消化系統問卷」 (Digestion Questionnaire)
- 如曾接受胃鏡檢查 / 活組織檢查，須遞交報告
- 如情況嚴重，或須索取主診醫生報告 (MAR) 或體檢 (Medical Exam)

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

胃食道反流 (Gastroesophageal Reflux Disease)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
完全康復 無病變紀錄、其他相連疾病或併發症	標準			
伴有嚴重症狀 或未進行全面檢查	擱置受保			

消化性潰瘍 (Peptic Ulcer)

簡介

- 胃或十二指腸內黏膜受到破損
- 嚴重的消化性胃潰瘍會出現併發症；如消化道出血和急性穿孔的情況

病徵

- 易飽、多胃氣、上腹脹痛、沒有胃口及嘔吐等現象
- 併發症包括「出血」、「穿洞」、甚至「幽門阻塞」

治療

- 口服藥物
- 嚴重或出現併發症則可能需要做手術

考慮因素

- 是否由酒精引致
- 治療方法及反應
- 引致的症狀或併發症種類

基本核保要求

- 遞交「消化系統問卷」(Digestion Questionnaire)
- 如曾接受胃鏡檢查 / 活組織檢查，須遞交報告
- 如情況嚴重，或須索取主診醫生報告 (MAR) 或體檢 (Medical Exam)

消化性潰瘍（Peptic Ulcer）

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
藥物治療及手術治療 （全胃切除手術除外）	標準	標準	標準 至 不保消化性潰瘍 [#]	標準
良性潰瘍 已進行全胃切除手術			標準 至 不保消化性潰瘍 [#]	

[#] 視乎上一次治療至今相距年期

^{*} 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

痔瘡 (Haemorrhoid)

簡介

- 當肛門的血管長時間受壓，導致附近的血液循環受到阻礙，便出現血管腫脹及血管墊組織突出，形成痔瘡

病徵

- 齒狀線以上的痔瘡稱為內痔，以下的為外痔，兩者同時出現便稱為混合痔
- 肛門無痛出血，通常在如廁或用廁紙清潔時發現或血漬沾污內褲
- 肛門有腫塊、肛門周圍皮膚痕癢或紅腫，如有外痔排便後會感痛楚不適

治療

- 外用 / 口服藥物
- 手術治療

考慮因素

- 是否已經完全切除
- 引致的症狀或併發症種類

基本核保要求

- 遞交「消化系統問卷」(Digestion Questionnaire)
- 詳述首出現徵狀的時間、治療方法、最後一次出現徵狀的時間
- 如曾接受腸鏡檢查，須遞交報告

痔瘡 (Haemorrhoid)

核保指引	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
手術治療 痔瘡已完全切除	標準	標準	標準 至 不保痔瘡 [#]	標準
未有進行切除			不保痔瘡 [#]	

[#] 視乎上一次治療至今相距年期
^{*} 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

結腸癌 (Colon Cancer)

簡介

- 於大腸生長的惡性腫瘤

病徵

- 大便有血、帶有黏液或呈黑色
- 大便習慣改變、體重下降、腹痛、嘔吐、貧血症狀等

治療

- 手術治療、化療、標靶治療及放射治療

考慮因素

- 癌症期數
- 接受過的治療種類
- 痊癒至今相距時間

基本核保要求

- 主診醫生報告 (MAR) 或由客戶遞交醫療報告及病理報告

結腸癌 (Colon Cancer)

核保指引

核保指引	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
第一至二期結腸癌	標準 至 擱置受保 #	不保 大腸癌及大腸原位癌 至 擱置受保 #	不保大腸 至 擱置受保 #	不保 大腸癌及大腸原位癌 至 擱置受保 #
第三期結腸癌		拒絕受保		
第四期結腸癌	拒絕受保			

視乎患癌時年齡、癌症期數、病理及完成癌症治療的年期

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

結腸息肉 (Colon Polyp)

簡介

- 任何在腸壁中的突起物都泛指為息肉

病徵

- 大部份息肉在早期徵狀並不明顯
- 部份可能會大便習慣改變、大便出血、糞便帶有黏液，甚至貧血等

治療

- 醫學監察
- 手術切除，並根據數量以及病理報告安排定期腸鏡檢查作監察

考慮因素

- 是大腸息肉數量及種類
- 是否已經完全切除
- 引致的症狀或併發症種類

基本核保要求

- 遞交「消化系統問卷 / 腫瘤問卷」 (Digestion / Tumour Questionnaire)
- 遞交所有檢查報告 (包括腸鏡報告及病理報告)
- 如未能提供腸鏡報告以及病理報告，須索取主診醫生報告 (MAR)

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

結腸息肉 (Colon Polyp)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
只有一粒息肉 已做切除手術並提交報告 確定為良性 / 低度細胞病變	標準		標準 至 不保事項 ^{1,2}	標準
已做切除手術並提交報告 確定為原位癌 / 高度細胞病變	標準 至 加價	加價 至 不保大腸癌 及大腸原位癌	不保事項 ^{1,2} 至 擱置受保	加價 至 不保大腸癌 及大腸原位癌
未有切除	擱置受保			

¹ 所有醫療產品 (保誠加護一生住院現金儲蓄保險 (ENCASH) 除外)：不保大腸。

² 保誠加護一生住院現金儲蓄保險 (ENCASH) 專屬核保指引：不保 1) 大腸息肉 或 2) 大腸的良性或惡性腫瘤。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

幽門螺桿菌感染 (*Helicobacter pylori*)

簡介

- 任微需氧的細菌，生存於胃部及十二指腸的各區域內
- 它會引起胃黏膜輕微的慢性發炎，甚或導致胃及十二指腸潰瘍與胃癌

病徵

- 大多於85%的感染幽門螺桿菌的人不會感到任何症狀或併發症
- 急性感染可能會引發帶有胃痛或噁心的急性胃炎。由此引發的慢性胃炎，其症狀（如果存在的話）等同於非潰瘍性的消化道症狀：胃痛、噁心、胃脹、打嗝、嘔吐、黑色糞便等

治療

考慮因素

- 藥物三聯療法
- 有否出現併發症
- 有沒有給予任何治療

基本核保要求

- 最新的尿素呼氣測試
- 最新的胃活檢報告（如有）

幽門螺桿菌感染 (Helicobacter pylori)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
只於常規檢查內發現 呼氣測試為陽性； 沒有被建議做胃鏡檢查； 沒有相關家族病史； 並沒有胃炎、貧血、 任何病徵或併發症	標準		不保胃	標準
曾做胃鏡 / 有任何病徵或併發症	根據診斷 / 病因 / 病徵 / 嚴重程度 / 風險因素作核保 如客戶被確診為胃炎 / 消化性潰瘍 可參閱「胃炎 (Gastritis) 」 / 「消化性潰瘍 (Peptic Ulcer) 」			



兒童疾病

1. 川崎病
2. 早產
3. 新生兒黃疸
4. 自閉症
5. 專注力不足 / 過度活躍症

泌尿系統疾病

1. 血尿症
2. 蛋白尿症
3. 腎石
4. 腎血管平滑肌脂肪瘤

川崎病 (Kawasaki Disease)

簡介

- 一種急性發熱性兒童疾病，較差情況可引起心肌炎和血管發炎

病徵

- 持續性發熱五天或以上、手紅腫後脫皮、身體出現紅色皮疹、口唇潮紅乾裂、舌頭充滿紅點、雙眼結膜充血、頸部淋巴腺腫大等
- 有可能影響到心臟及令心臟血管擴張

治療

- 藥物治療、注射免疫球蛋白

考慮因素

- 有有否影響心臟
- 病情及治療持續多久
- 甚麼時候開始停藥

基本核保要求

- 提供治療中及治癒後之心臟超聲波報告
- 驗身 (Medical Exam)
- 主診醫生報告 (MAR) (如有須要)

川崎病 (Kawasaki Disease)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
冠狀動脈未受影響 完全康復超過一年	標準			
曾經 / 現在 冠狀動脈不正常	加價 至 拒絕受保 #	個別考慮 #	拒絕受保	標準

視乎之前冠狀動脈擴張之大小及治癒後之心臟超聲波報告結果。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

早產 (Prematurity)

簡介

- 懷孕週數未滿 37 週之生產
- 出生體重低於 2500 公克為低體重；出生體重低於 1500 公克為極低體重

病徵

- 早產兒合併症如高黃疸血症、敗血症、呼吸道疾病、後晶體纖維化導致失明或顱內出血、腦性麻痺等

治療

- 跟據不同病徵而作出適切治療

考慮因素

- 身高及體重發展是否正常
- 智力、體能、聽力、視力等發展情況
- 是否有正常呼吸功能或有早產引起之先天性疾病

基本核保要求

- 詳述早產情況、治療、檢查結果及併發症
- 提供兒童健康紀錄簿及早產出院紀錄

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

早產 (Prematurity)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
出生體重 700 - 999公克 (g) 或 出生周數 24 - 27周		擱置受保至 5 歲； 5 歲後視乎驗身情況		
出生體重 1000 - 1499公克 (g) 或 出生周數 28 - 31周		擱置受保至 3 歲； 3 歲後視乎驗身情況		
出生體重 1500 - 1899公克 (g) 或 出生周數 32 - 36周		擱置受保至 1 歲； 1 歲後視乎驗身情況		
出生體重 1900 - 2499公克 (g) 及 出生周數 35 - 36周		個別考慮，有機會標準	擱置受保至 1 歲； 1 歲後視乎驗身情況	

新生兒黃疸 (Neonatal jaundice)

簡介

- 嬰兒出生後，所需的紅血球數量比胎兒期少，因此紅血球分解會暫時增加，並產生膽紅素。由於初生嬰兒的肝臟未完全成熟，不能及時處理積聚的膽紅素，便會出現新生嬰兒黃疸。
- 新生嬰兒黃疸一般會在出生後第二至第三天出現。大約到兩至三個星期，嬰兒的肝臟能有效地處理膽紅素，黃疸便會減退。

若有以下情況，膽紅素會相對較高：

- 早產
- 與母親的血型不吻合
- 餵哺情況不理想
- 感染
- 葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症
- 皮膚及眼白會呈現黃色。

病徵

治療

- 很多嬰兒都無須接受治療，隨着肝臟慢慢成熟，黃疸便會漸漸消失。
- 不過，當膽紅素過高或急速上升時，嬰兒便要到醫院接受適當的治療，例如光線治療，俗稱「照燈」。

考慮因素

- 成因、治療方法、康復進度、是否有需要覆診

基本核保要求

- 詳述發病成因、治療方法、康復進度及是否有需要覆診
- 出院紙 (如有需要)

新生兒黃疸 (Neonatal jaundice)

核保指引		人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌病
無需接受治療	已完全康復、沒有出現併發症 [#] 及無需接受醫療跟進	標準			
只需要接受照光治療					
需要接受其他治療 / 未完全康復 / 有出現併發症 [#] / 仍需接受醫療跟進		個別考慮			
如受保人為早產嬰兒		請參閱「早產（ Prematurity ）」			
[#] 例如癲癇發作、餵食不佳、發育遲緩、失聰及腦麻痺					

自閉症 (Autism)

簡介

病徵

- 為一種腦部因發育障礙所導致的疾病
- 其特徵是情緒表達困難、社交互動障礙、語言和非語言的溝通有問題
- 以及日常上常見的，表現出限制的行為與重複的動作，明顯的特定興趣
- 不能進行正常的語言表達和社交活動，常做一些刻板 and 守舊性的動作和行為

治療

- 跟進儘早實施適合兒童個人發展需要的干預策略
- 這些策略包括行為管理，言語或職業治療，醫療管理和社區支持

考慮因素

- 發病年齡
- 嚴重程度
- 治療方法

基本核保要求

- 遞交心理學家或精神病學家報告
- 如未能提供上述報告，須索取主診醫生報告 (MAR)

自閉症 (Autism)

核保指引

核保指引	人壽	早期危疾	危疾	醫療	癌症
≤ 2 歲	擱置受保	擱置受保	擱置受保	拒絕受保	標準
> 2 歲	視乎自閉症的嚴重程度及有沒有任何其他精神、情緒、行為等問題而定#				
	標準、加價 至 擱置受保	不保 嚴重精神病 至 擱置受保	標準 至 擱置受保		

[#] 視乎醫療報告及/或評估報告結果。

* 如投保「誠保一生」危疾保，兒童疾病保障部份將不保嚴重自閉症。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

專注力不足 / 過度活躍症

(Attention Deficit and Hyperactivity Disorder)

簡介

- 一個與腦神經發育相關的心理疾患，也是一個與腦神經相關的疾病

病徵

- 容易分心，難以專注
- 過度的活動或難以控制自身的言行舉止；且不符合患者年齡該有的成熟度

治療

- 藥物治療合併行為治療是目前證實最有效的治療方式

考慮因素

- 發病年齡
- 嚴重程度
- 治療方法

基本核保要求

- 遞交心理學家或精神病學家報告
- 如未能提供上述報告，須索取主診醫生報告 (MAR)

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。
* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

專注力不足 / 過度活躍症

(Attention Deficit and Hyperactivity Disorder)

核保指引

	人壽	危疾	早期危疾	醫療	癌症
視乎程度及沒有任何精神、情緒、行為等問題	標準、加價 至 擱置受保 (視乎歲數 及產品而定)	標準 至 擱置受保	不保 嚴重精神病 至 擱置受保	> 8 歲： 加價 至 拒絕受保	標準
				≤ 8 歲： 擱置受保	

血尿症 (Hematuria)

簡介

- 尿液中有過量血液或紅血球

血尿程度	試紙測試 (Urinalysis)	顯微鏡尿液分析 (RBC/hpf)
微量	交界性顏色變化	1 - 4
輕度	+	5 - 9
中度	++	10 - 19
嚴重	≥+++	≥ 20

病徵

- 大部分人沒有症狀，部分人或有排尿疼痛或困難的情況

治療

- 根據引致血尿的成因：如尿道炎、腎石及腫瘤等作出相應治療

考慮因素

- 年齡
- 血尿嚴重性；是否同時有蛋白尿症
- 治療時期長短及病情是否受控、接受治療種類、是否需要定期覆診及長期服用藥物

基本核保要求

- 尿液分析：尿液常規檢驗 (MU)

血尿症（Hematuria）

核保指引

核保指引		人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
< 55 歲	微量	標準			
	輕度	標準	標準 至 加價	標準	
	中度	加價	個別考慮	加價 或 不保泌尿系統	擱置受保
	重度			擱置受保	
≥ 55 歲	微量	標準		擱置受保	標準
	輕度	加價			
	中度 至 重度		擱置受保		

* 以上指引只適用於未能尋找病因的血尿症；如已發現病因，應以該病因作核保。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

蛋白尿症 (Proteinuria)

簡介

- 尿液中有過量蛋白質

血尿程度	試紙測試 (Urinalysis)	Mg/dl
微量	±	< 20
輕度	+	21 - 65
中度	++	66 - 135
嚴重	≥++	136 - 200

病徵

- 尿液有持久難消的泡沫、水腫等

治療

- 根據引致蛋白尿的成因：如尿道炎、腎石及腫瘤等作出相應治療

考慮因素

- 蛋白尿嚴重性
- 是否有其他心腦血管疾病
- 治療時期長短及病情是否受控、接受治療種類、是否需要定期覆診及長期服用藥物

基本核保要求

- 尿液分析：尿液常規檢驗 (MU)
- 驗血：腎功能測試 (RFT)

蛋白尿症 (Proteinuria)

核保指引

核保指引	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
微量 *腎功能正常及其他檢查完全正常	標準			
輕度	加價	加價	加價 至 不保泌尿系統	標準
中度		擱置受保		
重度		擱置受保		

* 以上指引只適用於未能尋找病因的蛋白尿症；如已發現病因，應以該病因作核保。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

腎石 (Renal Stone)

簡介

- 尿液中的礦物質結晶沉積在腎臟

病徵

- 腰痛、血尿等，但亦可沒有徵狀

治療

- 自然排出、體外震波碎石術、內視鏡輔助治療或手術

考慮因素

- 尿液分析及驗血等結果
- 曾接受治療種類？(如：體外震波碎石術、內視鏡輔助治療或手術等)
- 有否出現併發症？(如：腎病引起高血壓、腎積水、腎功能衰竭等)
- 腎石是否已治癒及治癒多久？是否需要定期覆診？

基本核保要求

- 驗詳述病發情況、症狀、檢查結果（單邊或雙邊）、治療情況及併發症
- 尿液分析：尿液常規檢驗 (MU)
- 如曾進行體外震波碎石術或其他手術，請提交手術報告及術後檢查報告

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

腎石 (Renal Stone)

核保指引

核保指引		人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
有腎石病史； 腎功能及血壓正常， 沒有血尿		標準	完全康復 > 1 年：標準	一次發病，完全康復 > 2 年：標準	標準
				否則，不保泌尿道結石	
現有腎石； 腎功能及血壓正常， 沒有症狀		標準	所有危疾產品 (CIT2除外)： 標準	多次發病，完全康復 > 5 年：標準	
				否則，不保泌尿道結石	
				不保泌尿道結石	
單邊腎石	標準	CIT2：+50%	所有危疾產品：加價	不保泌尿道結石	
					雙邊腎石

腎血管平滑肌脂肪瘤 (Renal Angiomyolipoma)

簡介

- 由血管、肌肉、脂肪的不正常增生而形成的「腎血管肌肉脂肪瘤」，是一種沒有病徵的良性腫瘤

病徵

- 一旦長大至4公分或以上，便有三分二機會引起腰痛
- 而且瘤裏面常有彎曲擴張的血管或血管瘤，以致有一半機會因血管破裂而出血，其中三分一更會大量出血，造成生命危險
- 其他症狀包括腹部有明顯的腫塊、血尿等。而且，肥大的腫瘤會佔用腎臟空間，壓迫腎組織，有可能破壞腎功能

治療

- 手術切除

考慮因素

- 腎血管平滑肌脂肪瘤的大小及穩定性
- 有否出現併發症、有否被建議或接受任何治療及有否進行手術切除

基本核保要求

- 腎臟超聲波
- 遞交過往的腎臟超聲波報告作比較

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

腎血管平滑肌脂肪瘤（Renal Angiomyolipoma）

核保指引	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
已切除並確診為良性； 未曾出現任何併發症	標準			
未有切除	個別考慮 (視乎超聲波結果及與過往超聲波之比較)			



生殖系統疾病

1. 子宮纖維瘤
2. 子宮內膜異位症
3. 子宮 / 宮頸息肉
4. 宮頸炎
5. 宮頸上皮內瘤樣病變
6. 單純性卵巢囊腫
7. 卵巢癌
8. 卵巢畸胎瘤
9. 多囊卵巢綜合症
10. 前列腺特異性抗原上升
11. 前列腺鈣化灶
12. 良性前列腺增生

子宮纖維瘤 (Uterine Fibroid)

簡介

- 子宮肌肉形成的良性腫塊，又稱肌瘤、子宮肌瘤或平滑肌瘤

病徵

- 經期過多、經痛、腹痛或腹部隆起、尿頻或尿渚留、影響生育或沒有病徵

治療

- 手術切除
- 藥物治療（主要用於控制徵狀）
- 醫學觀察

考慮因素

- 囊腫、結節或腫瘤種類及性質
- 曾否進行切除手術、細針抽取細胞檢查或其他活體組織切片
- 有否病徵或併發症

基本核保要求

- 「腫瘤問卷」(Tumour Questionnaire)
- 過往之檢查報告：包括超聲波檢查、其他造影檢查報告（如電腦掃瞄或磁力共振報告）及病理報告（如已做切除手術）

子宮纖維瘤 (Uterine Fibroid)

核保指引

核保指引		人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
未有進行手術		標準	標準	不保子宮纖維瘤	標準
子宮肌瘤切除術	< 3年			不保子宮纖維瘤	
	≥ 3年，沒有復發			標準	
子宮切除術					

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

子宮內膜異位症 (Endometriosis)

簡介

- 子宮內膜出現在子宮腔以外的位置

病徵

- 經痛、腹痛、月經不正常出血、不孕或沒有病徵

治療

- 手術切除
- 藥物治療 (主要用於控制徵狀)
- 醫學觀察

考慮因素

- 曾否進行手術及檢查結果
- 有否病徵或併發症

基本核保要求

- 「一般健康問卷」(General Health Questionnaire)
- 過往之檢查報告：
包括超聲波檢查、其他造影檢查報告 (如電腦掃瞄或磁力共振報告) 及
病理報告 (如已做切除手術)

子宮內膜異位症（ Endometriosis ）

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
已進行全子宮切除術和雙側輸卵管卵巢切除術，完全康復	標準			
其他情況	標準		不保子宮內膜異位症	標準

子宮 / 宮頸息肉 (Endometrial / Cervical Polyp)

簡介

- 子宮頸息肉是生長於宮頸的細小組織，息肉通常良性（非癌症），可單一或成群生長
- 子宮內膜息肉是細小的良性腫瘤，生長在子宮內壁。
可能會引起一些症狀如：經血量增加及不正常月經出血

病徵

- 經痛、腹痛、月經不正常出血、不孕或沒有病徵

治療

- 可用婦科小手術與宮頸檢查 / 宫腔鏡摘除息肉

考慮因素

- 息肉是否已切除
- 病理結果

基本核保要求

- 遞交子宮 / 子宮頸息肉病理報告

子宮息肉 / 宮頸息肉 (Endometrial Polyp / Cervical Polyp)

核保指引

		人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
已切除子宮息肉 / 子宮頸息肉 ; 病理結果為良性		標準			
未有切除	沒有 懷疑惡性 / 性質未明 / 可疑影像報告描述	標準	不保事項 ¹	不保事項 ²	不保事項 ¹
	懷疑惡性 / 性質未明 / 可疑影像報告描述	擱置受保			

¹ 不保子宮癌及子宮原位癌 / ¹ 不保子宮頸癌及子宮頸原位癌。
² 不保子宮的任何疾病或失調 / ² 不保子宮頸的任何疾病或失調。
* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

宮頸炎 (Cervicitis)

簡介

- 子宮頸炎是育齡婦女的常見病

病徵

- 主要表現為白帶增多，呈粘稠的粘液或膿性粘液，有時可伴有血絲或夾有血絲。長期慢性刺激是導致宮頸炎的主要誘因
- 慢性宮頸炎有多種表現，如宮頸糜爛、宮頸肥大、宮頸腺體囊腫、宮頸內膜炎等，其中以宮頸糜爛最為多見

治療

- 可用電烙術或用葯物塗搽，但嚴重者亦可能需要手術切除部份子宮頸

考慮因素

- 是否帶有鱗狀病變 (ASCUS / CIN) / HPV 感染 / 其他宮頸抹片不正常結果

基本核保要求

- 遞交過往子宮頸抹片檢查 / 遞交病理報告 / 活檢報告 (如有)

宮頸炎 (Cervicitis)

核保指引

		人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
沒有 HPV 感染 / 異常抹片病史	已完全康復 > 3 個月 ; 沒有任何徵狀	標準			
	慢性宮頸炎 帶有徵狀	標準		不保生殖系統	標準
過往抹片顯示有鱗狀病變 / HPV 感染		請參閱 「宮頸上皮內瘤樣病變 / 宮頸原位癌 / 人類乳頭狀瘤病毒感染 (Cervical CIN/CIS and HPV Infection) 」 之基本核保要求			

宮頸上皮內瘤樣病變 / 宮頸原位癌 / 人類乳頭狀瘤病毒感染 (Cervical CIN/CIS and HPV Infection)

簡介

- **宮頸上皮內瘤樣病變 I (CIN I) / 低度鱗狀上皮內病變：**
最低危險的類型，表現為輕度的發育異常，也是不正常的細胞增殖。局限於宮頸上皮層的下1/3，病變部分與正常細胞層分界清楚。如果病情與HPV感染有關，通過一年左右的免疫反應疾病會康復，一切病情需要更長恢復時間
- **宮頸上皮內瘤樣病變 II (CIN II) / 高度鱗狀上皮內病變：**
不典型增生細胞占宮頸上皮層的下部2/3，病變部分與正常細胞層分界清楚
- **宮頸上皮內瘤樣病變 III (CIN III) / 高度鱗狀上皮內病變 / 子宮頸原位癌：**
不典型增生細胞幾乎浸及全上皮層，僅剩表面正常鱗狀上皮細胞
病情可能會判定為子宮頸原位癌

宮頸上皮內瘤樣病變 / 宮頸原位癌 / 人類乳頭狀瘤病毒感染 (Cervical CIN/CIS and HPV Infection)

病徵

- 宮頸上皮內瘤樣病變通常通過篩選試驗發現，比如通過巴氏塗片法進行子宮頸抹片檢查，檢測可能的癌前症狀
- 檢查若不正常，則需要子宮陰道鏡進行放大，或進行活體檢查

治療

- 對於CIN1型的患者，可通過時間自愈而選擇暫緩治療
- 然而對這些患者應定期密切隨診，定期行宮頸脫落細胞學及陰道鏡檢查
如果在12個月內，經過多次檢查病變仍持續存在或進展，就應該開始治療
- 對多數中度不典型增生、所有重度不典型增生及原位癌的患者，均應給予積極的治療，其中包括冷灼法、電烙術、燒烙術、行子宮頸電熱圈環切術或宮頸錐切術
有治療意義的HPV疫苗正在臨床試驗階段

考慮因素

- 子宮頸抹片檢查結果 / 活體檢查結果 / 發病年期

基本核保要求

- 遞交子宮頸抹片檢查
- 遞交病理報告 / 活檢報告

* 以上為基本核保要求，核保部將因應客人個別情況而要求其他檢查或 / 及遞交醫療報告。
* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

宮頸上皮內瘤樣病變 / 宮頸原位癌 / 人類乳頭狀瘤病毒感染 (Cervical CIN/CIS and HPV Infection)

核保指引

核保指引		人壽	危疾	早期危疾	醫療	癌症
CIN I	診斷後跟進之 子宮頸抹片報告正常	標準	標準	標準 至 不保子宮頸原位癌 (視乎產品、HPV結果、 康復年期而定)	≤ 2年：不保子宮 頸 > 2年：標準	標準
CIN II	完全切除； 病理報告證實無浸潤； 手術後至少6個月的跟 進之子宮頸抹片報告 正常				≤ 1年：擱置受保 >1年：不保子宮頸	≤ 6個月：擱置受 保 >6個月：標準
CIN III						
人類乳頭狀瘤病毒(HPV)陽性		標準	不保 子宮頸癌	不保子宮頸原位癌	不保子宮頸	不保 子宮頸癌及 子宮頸原位癌

單純性卵巢囊腫 (Simple Ovarian Cyst)

簡介

- 卵巢表面或內部裡含液體的腫塊

病徵

- 下腹痛、下腹不適、經痛、月經異常、不孕或無症狀

治療

- 可手術切除 / 藥物治療 (主要用於控制徵狀) / 醫學觀察

考慮因素

- 息囊腫、結節或腫瘤種類及性質
- 曾否進行切除手術
- 有否病徵或併發症

基本核保要求

- 盆腔超聲波檢查 (視乎情況)
- 「腫瘤問卷」(Tumour Questionnaire)
- 過往之檢查報告：
包括超聲波檢查、其他造影檢查報告 (如電腦掃描或磁力共振報告) 及
病理報告 (如已做切除手術)

單純性卵巢囊腫（ Simple Ovarian Cyst ）

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
已完全切除	標準			
未有完全切除	標準		不保卵巢囊腫	標準

卵巢癌 (Ovarian Cancer)

簡介

- 於卵巢 (女性的生殖腺體) 生長的惡性腫瘤

病徵

- 初期可以沒有病徵，後期可有腹脹、盆腔或腹部疼痛，迅速飽食感及尿頻尿急等

治療

- 手術治療、化療、標靶治療、激素治療及放射治療

考慮因素

- 癌病程度 / 分期
- 接受過的治療種類
- 痊癒至今相距時間

基本核保要求

- 主診醫生報告 (MAR) 或由客戶遞交醫療報告及病理報告

卵巢癌 (Ovarian Cancer)

核保指引	人壽	危疾	早期危疾	醫療	癌症
卵巢癌 I 期	標準	加價 至 擱置受保	加價 及 不保卵巢原位癌 至 擱置受保	加價 至 擱置受保	加價 至 擱置受保
卵巢癌 II 期	標準 至 加價	拒絕受保			
卵巢癌 III 期	拒絕受保				
卵巢癌 IV 期					

卵巢畸胎瘤 (Ovarian Teratoma)

簡介

- 畸胎瘤是一種常見的卵巢腫瘤，來源於多能性生殖細胞，發病率佔全部卵巢原發性腫瘤的15%
- 畸胎瘤主要分成兩種類型，即「成熟型畸胎瘤」與「未成熟型畸胎瘤」

病徵

- 畸胎瘤的發生位置會帶來不同的症狀
長在卵巢會造成腹部骨盆腔附近疼痛

治療

- 手術治療

考慮因素

- 是否已進行手術切除
- 病理為「成熟型畸胎瘤」還是「未成熟型畸胎瘤」
- 切除年期

基本核保要求

- 遞交病理報告或詳述畸胎瘤的類型

卵巢畸胎瘤（Ovarian Teratoma）

核保指引

核保指引			人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
已切除	病理為成熟型畸胎瘤	< 1 年	標準	擱置受保		標準
		> 1 年	標準		+50%	
	病理為未成熟型畸胎瘤		標準 至 加價	拒絕受保	+50% 至 擱置受保	
未有切除			擱置受保			

多囊卵巢綜合症 (Polycystic Ovarian Syndrome)

簡介

- 女性因雄性激素上升所導致的症狀

病徵

- 多囊性卵巢的症狀包含月經不規律或是無月經、月經量過多、多毛症、粉刺、盆腔疼痛、難以受孕與黑棘皮症
- 相關的病症包含第二型糖尿病、肥胖症、阻塞性睡眠呼吸暫停、心血管疾病與子宮內膜癌

治療

- 飲食控制及藥物治療

考慮因素

- 有否出現併發症
- 驗血結果是否正常

基本核保要求

- 空腹血糖 (FBS) 及糖化血色素 (HbA1c)
- 血脂組合 (Lipid Profile)

多囊卵巢綜合症 (Polycystic Ovarian Syndrome)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
驗血結果完全正常； 沒有其他心血管疾病或併發症	標準		不保事項#	標準
有其他心血管疾病或併發症	加價、不保事項# 至 擱置受保			

#不保卵巢的良性或惡性腫瘤及囊腫。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

前列腺特異抗原上升 (Elevated PSA Level)

簡介

- 血液中有過量前列腺特異性抗原
- 除可見於前列腺癌外，其他情況如前列腺肥大、前列腺炎、尿道炎或其他令前列腺受損害之情況如前列腺活檢或手術等

病徵

- 情況輕微可以沒有病徵，如是前列腺癌或炎症有機會有小便頻密或夜尿頻密、小便或射精時赤痛、小便困難、小便或精液帶血等
- 如前列腺癌已轉移，患者可感到疲倦、胃口不佳、消瘦及骨痛等

治療

- 根據引致前列腺特異性抗原增高的成因：如尿道炎及腫瘤等作出相應治療

考慮因素

- 年齡
- 前列腺特異性抗原數值及有否上升趨勢
- 曾否接受活檢及病理報告結果
- 接受治療種類、是否需要定期覆診或服用藥物

基本核保要求

- 驗血：前列腺特異性抗原 (PSA)
- 過往之檢查報告：包括造影檢查報告及驗血報告

前列腺特異抗原上升 (Elevated PSA Level)

核保指引

核保指引		人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
曾有偶發性 前列腺特異 抗原上升； 並沒有任何 症狀及無需 進一步檢查	PSA ≤ 2.50 ng/ml	標準 [#]			
	PSA 2.50-4.00 ng/ml	標準 至 加價 [#]	標準 至 不保事項 ^{#^}	標準 至 擱置受保 [#]	標準 至 不保事項 [^]
	PSA 4.01-9.99 ng/ml	加價 至 擱置受保 [#]	不保事項 [^] 至 擱置受保 [#]		不保事項 [^]
	PSA >9.99 ng/ml	擱置受保			
其他情況		個別考慮			

視乎受保人歲數而定。

^ 不保前列腺癌及早期前列腺癌。

* 只適用於單純性前列腺鈣化灶；前列腺囊腫 / 結節或其他佔位性病變則需要提交最新超聲報告予醫生作個別審核。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

前列腺鈣化灶 (Prostate Calcification)

簡介

- 前列腺發生炎症後留下的疤痕，也可以是結石的前兆

病徵

- 小的鈣化灶大多沒有徵狀，大的鈣化灶有可能引起排尿阻礙，也伴隨著慢性前列腺炎徵狀

治療

- 沒有徵狀者並不需要治療，但需要排查及醫治引發前列腺鈣化的成因

考慮因素

- 投保人的年齡
- 超聲波與血液檢驗報告

基本核保要求

- 最近一年的 PSA 驗血結果

前列腺鈣化灶 (Prostate Calcification)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
沒有徵狀， 於體檢中發現 而驗血結果正常	標準 # # 註：只適用於沒有進行進一步的血液檢查、活體組織檢查或外科手術；造影檢查結果正常、沒有任何徵狀與不適及醫生沒有建議作進一步檢查			
因有徵狀曾求醫 / 有其他異常情況 / 驗血結果異常	個別考慮 如驗血結果不正常， 請參閱「前列腺特異抗原上升 (Elevated PSA Level) 」 之基本核保要求			

* 只適用於單純性前列腺鈣化灶；前列腺囊腫 / 結節或其他佔位性病變則需要提交最新超聲報告予醫生作個別審核。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

良性前列腺增生 (Benign prostatic hyperplasia)

簡介

- 前列腺是男性的生殖腺，負責製造濃液混和精子形成精液。良性前列腺肥大症是腺狀組織出現非癌症增生，導致前列腺肥大。
- 良性前列腺肥大相信是男性正常衰老的生理過程，亦是年長男性常見的病症。
- 儘管這種病屬於良性增生，但當腺狀組織不斷肥大，會嚴重堵塞尿道，阻礙正常排尿。

病徵

- 尿急：難以忍尿
- 夜尿：晚上醒來小便
- 等尿：等一會才能小便
- 小便流量微弱
- 尿頻：小便的次數增多
- 小便時感到灼痛或刺痛

治療

- 外科手術
- 藥物治療

考慮因素

- 前列腺特異性抗原 (PSA) 控制
- 排尿阻塞程度
- 有沒有影響腎臟

基本核保要求

- 前列腺特異性抗原 (PSA)
- 前列腺超聲波(如有需要)

良性前列腺增生 (Benign prostatic hyperplasia)

核保指引

核保指引	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療		癌病
輕微阻塞症狀、前列腺光滑、沒有結節、腎功能正常、前列腺特異抗原 PSA 及 顯微鏡尿液分析 正常	標準	標準	沒有進行手術	不保前列腺	標準
			曾進行手術，已完全康復		
			≤ 1年	不保前列腺	
			> 1年	標準	
中度或嚴重阻塞症狀 / 腎功能異常 / 需要導尿	個別考慮				
前列腺特異性抗原異常	可參閱「前列腺特異抗原上升（ Elevated PSA Level ）」				



家族病史

1. 乳腺癌家族史
2. 卵巢癌家族史
3. 結腸直腸癌家族史
4. 帕金森病家族病史
5. 二型糖尿病家族史

乳腺癌家族史 (Family History of Breast Cancer)

* 只適用於女性受保人

簡介

- 有乳腺癌家族史明顯增加了患乳癌的風險，特別是在年輕時有直屬親系帶有病史
- 約 5% 至 10% 的乳腺癌病例的原因被認為是由於遺傳引致
- 醫學調查發現兩種基因 (BRCA1 和 BRCA2) 的攜帶者的乳癌發病風險大約為 85%
- 若受到突變影響，有一些基因會明顯增加患上乳腺癌的風險

考慮因素

- 患上乳腺癌的直屬親系數目
- 直屬親系患上乳腺癌的發病年齡

基本核保要求

- 詳述患上乳腺癌的直屬親系數目及發病年齡

乳腺癌家族史 (Family History of Breast Cancer)

* 只適用於女性受保人

核保指引

(只適用於新生意投保)

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
一位直系親屬 ≥ 40 歲時 被診斷患上乳腺癌	標準	所有危疾產品 (CIT2除外)：標準 (只適用於新生意投保或於保單行政部申請增加附加保障)	所有醫療產品 (PPM除外)：標準 (只適用於新生意投保或於保單行政部申請增加附加保障)	標準
		CIT2： 加價 至 不保事項^#	PPM： 不保 乳房 及 卵巢	
一位直系親屬 < 40 歲時 被診斷患上乳腺癌		所有危疾產品 (CIT2除外)： +50% / 不保事項^	所有醫療產品： 不保 乳房 及 卵巢	不保事項^
		CIT2： 加價 至 不保事項^#		
多於一位直系親屬 被診斷患上乳腺癌	標準 至 加價#	所有危疾產品：加價 至 不保事項^#		

^ 不保乳癌、乳房原位癌、卵巢癌 及 卵巢原位癌。

視乎直系親屬發病年齡及受保人歲數。

* 以上核保指引只適用於單一癌症家族史。如受保人有多於一個癌症家族史(不論癌症是否源自同一部位)，以上指引將不適用。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

卵巢癌家族史 (Family History of Ovarian Cancer)

簡介

- 卵巢癌家族史是該病的重要危險因素
- 然而，少於5%的病例是真正的遺傳性卵巢癌，其中至少有兩位或以上直系親屬患有高滲透性常染色體顯性遺傳模式

考慮因素

- 患上卵巢癌的直系屬親數目
- 直系親屬患上卵巢癌的發病年齡

基本核保要求

- 詳述患上卵巢癌的直系親屬數目及發病年齡

卵巢癌家族史 (Family History of Ovarian Cancer)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
只有一位直系親屬被診斷患上卵巢癌	標準			
超過一位直系親屬被診斷患上卵巢癌	標準 至 加價	加價 至 不保卵巢癌、卵巢原位癌、乳癌、乳房原位癌 [#]	加價 至 不保 卵巢 及 乳房	加價 及 不保卵巢癌、卵巢原位癌、乳癌、乳房原位癌

[#] 視乎直系親屬發病年齡及受保人歲數。

* 以上核保指引只適用於單一癌症家族史。如受保人有多於一個癌症家族史(不論癌症是否源自同一部位)，以上指引將不適用。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

結腸直腸癌家族史 (Family History of Colon Cancer)

簡介

- 直系親屬 (包括父母、兄弟姊妹) 被診斷有結腸直腸癌

病徵

- 大部份瘰肉在早期徵狀並不明顯
- 部份可能會大便習慣改變、大便出血、糞便帶有黏液，甚至貧血等

治療

- 定期身體檢查以作預防治療

考慮因素

- 受保人年齡
- 確診結腸直腸癌直系親屬的人數

基本核保要求

- 詳述其直系親屬關係、癌症種類及準確發病年齡
- 遞交所有有關檢查報告 (包括腸鏡報告)

結腸直腸癌家族史 (Family History of Colon Cancer)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
一位直系親屬 確診結腸直腸癌	標準	標準	標準 至 不保大腸	標準 至 加價* (保費級別視乎 直系親屬發病年齡及受保人年齡)
多於一位 直系親屬確診結腸直腸癌 (受保人年齡為 50 歲或以上)			不保大腸	加價
多於一位 直系親屬確診結腸直腸癌 (受保人年齡為 50 歲以下)	加價	不保 大腸癌及大腸原位癌		不保 大腸癌及大腸原位癌

* 以上核保指引只適用於單一癌症家族史。如受保人有多於一個癌症家族史(不論癌症是否源自同一部位)，以上指引將不適用。

* 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

帕金森病家族病史

(Family History of Parkinson's Disease)

簡介

- 帕金森氏症慢性神經退化疾病，以影響運動神經為主，初期表現為顫抖，肢體僵硬，症狀通常逐漸惡化，後期也可能有認知或行為問題；成因還未明確，但普遍認為和遺傳與環境有關
- 有此病家族史的人較可能得到此病，15% 的病患都有親屬罹患帕金森氏症

治療

- 帕金森氏症目前無法治癒，症狀可用藥物減低

考慮因素

- 患有帕金森病的直系親屬數目及其發病年齡
- 投保人的年齡

基本核保要求

- 詳述患上帕金森病的直系親屬數目及發病年齡
- 驗身 (Medical Exam)
- 遞交基因檢測結果 (如有)

帕金森病家族病史

(Family History of Parkinson's Disease)

核保指引

	人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌症
只有一位直系親屬於 50 歲前患有帕金森病 而受保人年齡大於 50 歲及驗身完全正常； 或 只有一位直系親屬於 50 歲後患有帕金森病； 或 多於一位直系親屬均於 65 歲後患有帕金森病	標準	標準	不保帕金森病	標準
其他情況		不保帕金森病 至 拒絕受保		

二型糖尿病家族史 (Family history of diabetes type 2)

簡介

- 直系親屬被診斷患有糖尿病

考慮因素

- 受保人年齡
- 患上糖尿病的直屬親系數目

基本核保要求

- 詳述其直系親屬關係、糖尿病種類及發病年齡
- 直系親屬包括父母及兄弟姊妹

二型糖尿病家族史 (Family history of diabetes type 2)

核保指引		人壽	早期危疾 / 危疾	醫療	癌病
一名家族成員被確診糖尿病:		標準 [#]			
兩名或以上 家族成員被 確診糖尿病:	其中一名家族成員於≤60歲被確診糖尿病				
	受保人投保年齡				
	≤ 55	標準 [#]		標準 [#]	標準 [#]
	>55 至 <65			標準 [#]	
	≥ 65 至 <70			標準 [#]	
	兩名家族成員於≤60歲被確診糖尿病				
	受保人投保年齡				
	≤ 55	標準 [#]		+50% [#]	標準 [#]
	>55 至 <65			標準 [#]	
	≥ 65 至 <70			標準 [#]	

[#] 如受保人本身有其他心血管疾病風險 (例如：過重、高血壓、高血脂、糖尿病等)有可能會導致加價。

^{*} 本指引僅限內部參考用途，不得對外(包括客戶或公眾人士)發放。公司將保留最終核保決定權。

註釋

驗血組合類別	組合包括
¹ Liver Function Test ¹ 肝功能檢驗	Alkaline Phosphatase + Bilirubin + SGOT + SGPT 鹼性磷酸酵素 + 膽紅素 + 谷草轉氨酵素 + 谷丙轉氨酵素
² Pru-liver Profile ² 保誠肝臟檢驗組合	¹ Liver Function Test + HBeAg + Alpha Feto Protein 肝功能檢驗 + 乙型肝炎 e 抗原 + 甲種胚胎蛋白
³ Lipid profile (Fasting 8 hours for this test) ³ 血脂組合 (檢驗前需空腹8小時)	Total Cholesterol + HDL Cholesterol + Triglycerides + LDL Cholesterol + VLDL 總膽固醇 + 高密度脂蛋白膽固醇 + 三酸甘油脂 + 低密度脂蛋白膽固醇 + 極低密度脂蛋白

最新超聲波指引

如客戶曾有過不正常的超聲波結果, 請根據以下最新超聲波指引：

情況		做法
1	客戶可提供該不正常的超聲波報告, 及報告日期是於一年內	請遞交該報告予核保部 核保部會根據該報告結果直接進行核保
2	客戶可提供該不正常的超聲波報告, 但報告日期已超過一年	請遞交該報告予核保部 核保部會審視不正常的結果, 並發出跟進事項便條： - 客戶請攜帶過往的超聲波報告及便條到保誠認可的化驗所以供放射科醫生作比較之用 - 如客戶同時安排了在保誠醫務中心進行驗身，醫生會根據客戶的身體狀況寫轉介信。請務必在進行超聲波檢查前將轉介信帶到保誠認可的化驗所給放射科醫生參考 (適用於香港投保申請)
3	客戶未能提供該不正常的超聲波報告	核保部會發出跟進事項便條 請自行填寫「超聲波檢查表格」(Ultrasound Examination Form) 並攜帶跟進事項便條到保誠認可的化驗所進行全新超聲波

最新超聲波指引

最新超聲波指引注意事項：

為方便放射科醫生對客戶的病況作比較，從而提升超聲波報告的準確度，理財顧問/客戶在進行超聲波檢查時，**必須**提供以下其中一項給化驗所的放射科醫生作參考：

- 最近期的超聲波報告(請自行複印副本)
- 保誠醫務中心發出的轉介信(適用於香港投保申請並已安排在健康評估中心進行驗身的客戶)
- 理財顧問自行填寫的「超聲波檢查表格」(Ultrasound Examination Form) (此表格可於PIL -UI000015 / UI000018 / UI000019 / UI000280 下載)，但請注意：

必須於電子投保申請題目“客戶是否已安排或正進行為此投保申請的驗身？”/ 紙本投保中於理財顧問報告題目6a註明已為客戶安排超聲檢查。理財顧問必須於「超聲波檢查表格」上清晰地填寫客戶的疾病名稱包括正確位置以提升超聲波報告的準確度。(例子：如客戶曾患有左乳房纖維瘤病史，請於超聲波檢查表格上疾病名稱一欄中填上“左乳房纖維瘤”。)

公司保留權利按下列情況要求理財顧問承擔超聲檢查的費用，一般會於理財顧問的佣金賬戶扣除：

- 非有核保需要而進行的檢查
- 客戶過往於本公司曾有不成功的投保申請記錄(即延遲承保/拒絕承保/不獲接納)，現再次投保，而公司於上一次投保申請時已承擔所有醫療費用
- 客戶要求就現有核保決定進行上訴而需遞交的醫療證明(例如：驗身或檢查報告)。
- 我們認可國內三甲醫院(一年內)/美年大健康(半年內)/愛康國賓(半年內)的醫療報告

常見直接拒絕受保 / 延期受保原因

常見直接拒絕受保 / 延期受保原因

健康狀況	核保決定 / 投保貼士 * 能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	需要延期受保 / 拒絕受保例子
出生時屬於早產嬰兒; 出生體重低於 2500 克 1. 出生體重 1500 - 2499克 或 出生周數 32 - 36 星期 : 投保時少於 1 歲; 或 2. 出生體重 1000 - 1499克 或 出生周數 28 - 31 星期 : 投保時少於 3 歲; 或 3. 出生體重 700 - 999克 或 出生周數 24 - 27 星期 : 投保時少於 5 歲	核保決定 人壽：延期受保 危疾：延期受保 醫療：延期受保	受保人35 週出生 ; 出生體重 2.08 公斤 ; 投保時 1 個月大
	何時才接受投保？ 出生體重 1500 - 2499克 或 出生周數 32 - 36 星期 : 足 1 歲後, 身高體重於正常範圍內; 所有檢查結果正常及 沒有其他健康問題 出生體重 1000 - 1499克 或 出生周數 28 - 31 星期 : 足 3 歲後, 身高體重於正常範圍內; 所有檢查結果正常及 沒有其他健康問題 出生體重 700 - 999克 或 出生周數 24 - 27 星期 : 足 5 歲後, 身高體重於正常範圍內; 所有檢查結果正常及 沒有其他健康問題 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	

常見直接拒絕受保 / 延期受保原因

健康狀況	核保決定 / 投保貼士 * 能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	需要延期受保 / 拒絕受保例子
冠心病	核保決定 人壽：按個別情況考慮 - 詳情請參考「醫療核保指引 Medbook Pru - 冠心病」 危疾：拒絕受保 醫療：拒絕受保 何時才接受投保？ 危疾及醫療：不接受投保 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	五年前, 曾因心絞痛入院 接受通波仔手術
自閉症, 投保時少於 2 歲	核保決定 人壽：延期受保 - 詳情請參「醫療核保指引 Medbook Pru - 自閉症」 危疾：延期受保 - 詳情請參「醫療核保指引 Medbook Pru - 自閉症」 醫療：拒絕受保 何時才接受投保？ 人壽：足 2 歲後, 視乎評估報告結果 危疾：足 2 歲後, 視乎評估報告結果 醫療：不接受投保 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	一歲半患上自閉症 每半年覆診一次

常見直接拒絕受保 / 延期受保原因

健康狀況	核保決定 / 投保貼士 * 能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	需要延期受保 / 拒絕受保例子
電腦掃描報告發現磨玻璃結節少於一年 再沒有進一步跟進	核保決定 人壽：延期受保 危疾：延期受保 醫療：延期受保 何時才接受投保？ 發現磨玻璃肺結節超過一年；之後有跟進, 並提供最新的影像報告, 與發現時的影像作比較 核保決定視乎跟進報告結果及結節大小 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	兩年前 CT 發現左肺磨玻璃結節 沒有再進行新一次的 CT
檢查報告中發現有腫物, 性質未明 沒有進一步跟進 (常見部位包括: 甲狀腺 / 乳房 / 前列腺 / 肺部 / 子宮 / 卵巢 / 肝臟 / 腎臟 / 胃部 / 大腸 / 等等...)	核保決定 人壽：延期受保 危疾：延期受保 醫療：延期受保 何時才接受投保？ 之後有跟進, 進一步檢查後醫生確定為良性 (須視乎不同部位的腫物) 某些部位腫物必需為已切除 (例如：胃部 / 大腸) 才能考慮接受投保，並需遞交病理報告及顯示性質確診為良性 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	超聲波報告發現甲狀腺左側葉囊性結節, 性質待查 客人沒有進一步跟進

常見直接拒絕受保 / 延期受保原因

健康狀況	核保決定 / 投保貼士 * 能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	需要延期受保 / 拒絕受保例子
檢查報告結果異常 醫生建議 / 或已安排進一步檢查	核保決定 人壽：延期受保 危疾：延期受保 醫療：延期受保	因年紀漸大, 醫生建議 下星期進行定期腸鏡檢查
	何時才接受投保？ 直至有進一步診斷結果 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	
癌症腫瘤標記(Tumor Marker)異常	核保決定 人壽：延期受保 危疾：延期受保 醫療：延期受保	曾於常規體檢驗出 卵巢癌腫瘤標記 (CA 19.9) 超出正常範圍 沒有跟進
	何時才接受投保？ 發現後半年, 最新癌症腫瘤標記血液檢查結果 已回復正常 (不同種類的癌症腫瘤標記的核保考慮會有不同, 按個別情況而定) 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	

常見直接拒絕受保 / 延期受保原因

健康狀況	核保決定 / 投保貼士 * 能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	需要延期受保 / 拒絕受保例子
癲癇 首次發作為一年內	核保決定 人壽：延期受保 危疾：延期受保 醫療：延期受保	半年前出現癲癇情況 抽搐持續兩分鐘, 現已痊癒
	何時才接受投保？ 首次發作 1 年後, 視乎受保人年齡、發作次數及嚴重程度 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	
中風	核保決定 人壽：延期受保 - 詳情請參「醫療核保指引 Medbook Pru - 中風」 危疾：拒絕受保 醫療：拒絕受保	五個月前中風 癱瘓四個月後可下床行動
	何時才接受投保？ 人壽：病發多於半年後 (視乎嚴重程度) 危疾及醫療：不接受投保 註：能否受保視乎最新檢查結果或客戶報告內容及或以非標準個案承保	

「誠保一生」危疾保 - 摯愛寶 (BCIM3) 「簡易投保」健康問題小貼士

「誠保一生」危疾保 - 摯愛寶 (BCIM3) 「簡易投保」健康問題小貼士

受保人(即孕婦)必須符合以下申請資格：

1. 受保人的懷孕是自然受孕或輔助受孕（如體外人工受精（IVF）），並現已懷孕22週或以上。
2. 受保人只懷有一個（1）或兩個（2）胎兒。
3. 受保人為自己而不是通過代孕母親懷有胎兒，並將在該嬰孩出生後成為其合法母親。
4. 投保申請前，受保人已接受註冊專科醫生的產前檢查，並已接受所有建議的產前篩查，包括驗血、當前懷孕的胎兒超聲波檢查。

「誠保一生」危疾保 - 摯愛寶 (BCIM3) 「簡易投保」健康問題小貼士

受保人(即孕婦)必需回答並通過以下「簡易投保」健康問題：

問題 1.	您目前懷有多少個胎兒？
貼士	如受保人懷有兩個 (2) 胎兒， • 受保人必須以相同的保額提交兩份「誠保一生」危疾保 - 摯愛寶 (BCIM3) 的申請；及 • 以下關於胎兒的健康資料申報是根據兩個胎兒的狀況，而不是只根據其中一個胎兒。 如受保人懷有三個 (3) 或以上胎兒，此投保申請將被拒絕。

「誠保一生」危疾保 - 摯愛寶 (BCIM3) 「簡易投保」健康問題小貼士

問題 2.	您曾否被診斷患有以下疾病或出現任何相關跡象或病徵：癌症、中風（包括暫時性腦缺血 (TIA) / 小中風）、心臟疾病*、任何孕前高血壓病史、糖尿病、甲狀腺功能亢進症、甲狀腺功能減退症、慢性腎炎、腎衰竭、乙型肝炎、丙型肝炎、人類免疫力缺乏症病毒感染 (HIV) / 愛滋病 (AIDS) 或抑鬱症？
貼士	受保人經註冊醫生診斷出抑鬱症以外的任何其他類型的精神疾病（例如：焦慮症、精神分裂症、雙相情感障礙 / 躁鬱症、精神病、飲食障礙等）將在問題 4（異常產前檢查或測試報告）中披露。 有關詳細資訊，請參閱問題 4 和問題 4 下的“貼士”部分。

「誠保一生」危疾保 - 摯愛寶 (BCIM3) 「簡易投保」健康問題小貼士

問題 3.	在確認懷孕後，您曾否使用任何煙草製品或飲用酒精飲料？（偶有 1 或 2 次而每次酒量 不超過 1 杯的社交型式飲酒除外。）
貼士	煙草製品是指香煙、雪茄、煙斗、咀嚼煙草和使用尼古丁替代產品（如電子煙、電子霧化器、尼古丁貼片等）。 飲用酒精飲料是指確認懷孕後有飲用 3 次或以上，每次最多 1 杯的酒精飲料（最多 30 毫升）。 確認懷孕包括通過家庭妊娠試驗試劑盒及/或醫生的診斷來確認。 <i>*如果胎兒被診斷出患有胎兒酒精綜合症，或者在任何索賠期間提到飲酒是風險因素，它將按照常規危疾索賠中的處理方式處理</i>

「誠保一生」危疾保 - 摯愛寶 (BCIM3) 「簡易投保」健康問題小貼士

問題 4. (1) 在您過往的任何一次懷孕期間 (如有) 或當前懷孕期間, 您曾否有過任何妊娠併發症史或嬰兒出生時患有先天性心臟病、血友病或脊柱缺陷?

貼士

妊娠併發症包括影響孕婦或產後媽媽、嬰兒或兩者健康的身體和精神狀況。這個問題包括過往任何時間及/或保單繕發之前為止的病史。以下列出的是妊娠併發症的提示清單。

與分娩有關的病史及/或併發症：

- a. 流產, 流產先兆, 自然流產, 胎兒死亡, 死產, 早產 (胎齡 36 周前出生的嬰兒)
- b. 孕期陰道出血或異常陰道出血

與懷孕器官有相關的併發症：

- a. 胎盤異常, 包括 胎盤粘連 / 胎盤植入 / 穿透性胎盤植入 / 胎盤早剝
- b. 羊水栓塞、羊水過少、羊水過多、絨毛膜羊膜炎

與胎兒位置有關的併發症：

- a. 異位妊娠
- b. 肩難產
- c. 臀位分娩
- d. 葡萄胎妊娠

「誠保一生」危疾保 - 摯愛寶 (BCIM3) 「簡易投保」健康問題小貼士

問題 4.(續)	(1) 在您過往的任何一次懷孕期間 (如有) 或當前懷孕期間，您曾否有過任何 妊娠併發症 史或嬰兒出生時患有先天性心臟病、血友病或脊柱缺陷？	
貼士	妊娠併發症包括影響孕婦或產後媽媽、嬰兒或兩者健康的身體和精神狀況。 這個問題包括過往任何時間及/或保單繕發之前為止的病史。以下列出的是妊娠併發症的提示清單。 妊娠疾病相關併發症： a. 彌散性血管內凝血 b. 子癇前期 (妊娠毒血症)或子癇、癲癇發作 c. 肺栓塞/深靜脈血栓形成 d. 高血壓/蛋白尿 e. 尿糖 /糖尿病 / 妊娠糖尿病 f. 妊娠期急性脂肪肝 g. 妊娠劇吐 h. 化膿性盆腔血栓形成或靜脈炎 i. 胎兒生長受限 /胎兒宮內發育遲緩 (IUGR) j. 妊娠滋養細胞疾病 k. HELLP 綜合症	
	l. 妊娠期血液高凝狀態 m. 胎兒酒精綜合症 n. 妊娠期甲狀腺疾病 o. 妊娠期肝內膽汁淤積 p. 妊娠期類天皰瘡 q. 妊娠皰疹炎 r. 妊娠相關性周圍神經炎 s. 妊娠期破傷風 t. 產後抑鬱症 u. 懷孕期間的任何住院治療或醫療指示的臥床休息(陰道分娩或剖腹產除外) <u>任何未列出的妊娠併發症只要符合以下條件均可接受：</u> 該妊娠併發症只在之前的懷孕期間發生，並且可以於現時懷孕期間確認不存在，或 者不影響母親或嬰兒。 產前檢查或測試報告中的任何異常發現是指在懷孕確認*後和保單繕發日期之前進行的任 何檢查或測試中發現有任何異常。 *確認懷孕包括通過家庭妊娠試驗試劑盒及/或醫生的診斷來確認。	

「誠保一生」危疾保 - 摯愛寶 (BCIM3) 「簡易投保」健康問題小貼士

問題 4.(續)	(2) 在您目前的懷孕期間，曾否患有或被主診醫生告知您的產前檢查或測試報告（包括但不限於超聲波、心電圖 (ECG)、血液檢查、基因測試、尿液檢查）有任何 <u>異常發現</u> ，或您曾感染過風疹（德國麻疹）或麻疹？		
貼士	以下列出的是產前檢查或測試報告中的任何<u>異常發現</u>的提示清單。 <table border="0"> <tr> <td data-bbox="471 464 1363 1320"> a. 孕婦一般身體檢查異常, 包括血壓異常、體重異常、子宮過早收縮、是否存在感染、精神健康情況異常 (例如：焦慮症、精神分裂症、雙相情感障礙 / 躁鬱症、精神病、飲食障礙 等) 等。 b. 胎兒一般檢查異常，例如胎兒心率異常、胎兒大小異常、胎兒體位異常、胎兒生長異常 等。 c. 任何血液檢查及/或其他檢查異常，例如血全圖、空腹血糖、乙肝、愛滋病病毒、腎功能、肝功能、感染（如風疹(德國麻疹)、巨細胞病毒、梅毒、衣原體、茲卡病毒）或妊娠期間被要求進行的任何其他檢查異常等。 d. 貧血或地中海貧血 e. 血友病 </td><td data-bbox="1363 464 2410 1320"> f. 凝血功能障礙疾病 g. 尿液檢查異常 h. 心電圖異常 i. 羊水檢查異常 j. 產前篩查染色體異常 k. 宮縮監測異常 l. 孕婦超聲或影像學檢查異常 m. 胎兒超聲或形態掃描監測異常 n. 妊娠糖尿病篩查或檢查異常 o. 陰道拭子檢查異常 p. 羊膜穿刺術或絨毛膜取樣異常 </td></tr> </table>	a. 孕婦一般身體檢查異常, 包括血壓異常、體重異常、子宮過早收縮、是否存在感染、精神健康情況異常 (例如：焦慮症、精神分裂症、雙相情感障礙 / 躁鬱症、精神病、飲食障礙 等) 等。 b. 胎兒一般檢查異常，例如胎兒心率異常、胎兒大小異常、胎兒體位異常、胎兒生長異常 等。 c. 任何血液檢查及/或其他檢查異常，例如血全圖、空腹血糖、乙肝、愛滋病病毒、腎功能、肝功能、感染（如風疹(德國麻疹)、巨細胞病毒、梅毒、衣原體、茲卡病毒）或妊娠期間被要求進行的任何其他檢查異常等。 d. 貧血或地中海貧血 e. 血友病	f. 凝血功能障礙疾病 g. 尿液檢查異常 h. 心電圖異常 i. 羊水檢查異常 j. 產前篩查染色體異常 k. 宮縮監測異常 l. 孕婦超聲或影像學檢查異常 m. 胎兒超聲或形態掃描監測異常 n. 妊娠糖尿病篩查或檢查異常 o. 陰道拭子檢查異常 p. 羊膜穿刺術或絨毛膜取樣異常
a. 孕婦一般身體檢查異常, 包括血壓異常、體重異常、子宮過早收縮、是否存在感染、精神健康情況異常 (例如：焦慮症、精神分裂症、雙相情感障礙 / 躁鬱症、精神病、飲食障礙 等) 等。 b. 胎兒一般檢查異常，例如胎兒心率異常、胎兒大小異常、胎兒體位異常、胎兒生長異常 等。 c. 任何血液檢查及/或其他檢查異常，例如血全圖、空腹血糖、乙肝、愛滋病病毒、腎功能、肝功能、感染（如風疹(德國麻疹)、巨細胞病毒、梅毒、衣原體、茲卡病毒）或妊娠期間被要求進行的任何其他檢查異常等。 d. 貧血或地中海貧血 e. 血友病	f. 凝血功能障礙疾病 g. 尿液檢查異常 h. 心電圖異常 i. 羊水檢查異常 j. 產前篩查染色體異常 k. 宮縮監測異常 l. 孕婦超聲或影像學檢查異常 m. 胎兒超聲或形態掃描監測異常 n. 妊娠糖尿病篩查或檢查異常 o. 陰道拭子檢查異常 p. 羊膜穿刺術或絨毛膜取樣異常		